

Agenda de Pesquisa e Ação para a América Latina e o Caribe

Lista de Autores

Dra. Natalie Greaves, Professora de Saúde Pública, Coordenadora MPhil/PhD em Saúde Pública e Epidemiologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade das Índias Ocidentais (UWI) Cave Hill

Dr. Satish Jankie, Professor de Farmacologia, Escola de Farmácia, Faculdade de Ciências Médicas, UWI St. Augustine

Dr. Shamjeet Singh, Professor de Ciências Básicas Integradas da Saúde, Escola de Farmácia, Faculdade de Ciências Médicas, UWI St. Augustine

Embaixador Gillian M. S. Bristol, Diretor do Centro Latino-Americano e do Caribe (LACC), UWI Mona

Dra. Elizabeth Mandeville, Consultora Independente

Dr. Michael Campbell, Professor Sênior de Ciências Comportamentais/Psicologia e Vice-Reitor (Pesquisa e Pós-Graduação), UWI Cave Hill

Nienke Meinsma, Pesquisadora Júnior de Políticas sobre Mudanças Climáticas e Saúde, Climate Cares Centre, Instituto de Inovação em Saúde Global, Imperial College London

Jessica Newberry Le Vay, Bolsista de Mudança Climática e Política de Saúde, Climate Cares Centre, Instituto de Inovação em Saúde Global, Imperial College London

Didi Thompson, Pesquisadora Honorária, Centro de Políticas de Saúde, Instituto de Inovação em Saúde Global, Imperial College London

Dra. Emma J Lawrance, Centro Climate Cares, Instituto de Inovação em Saúde Global, Imperial College London

Dra. Sandeep Maharaj, Diretor, Escola de Farmácia, Faculdade de Ciências Médicas, UWI St. Augustine

Índice

Resumen ejecutivo	3
Introdução	6
Histórico do Connecting Climate Minds	8
Metodologia	11
Estado atual e necessidades emergentes para as mudanças climáticas e saúde mental na América Latina e no Caribe	17
Agenda da pesquisa	21
Temas de pesquisa prioritários	21
Agenda de ação	26
Discussão: pontos fortes, limitações e próximos passos para a agenda de pesquisa e ação	33
Conclusão	34
Audiência da comunidade regional de prática	35
Glossário de termos	36
Quem produziu este relatório	36
Apêndice	41
Referências	59

Resumo executivo

Muitos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID) na Bacia do Caribe e países da América Latina continental enfrentam desafios econômicos e ambientais associados às mudanças climáticas.¹ No entanto, as mudanças climáticas também são cada vez mais reconhecidas como uma ameaça à saúde mental, agravando os riscos de um cenário precário em saúde mental e desestabilizando as condições necessárias para a efetiva saúde mental. Embora as pesquisas que tratam de alguma maneira de mudanças climáticas e saúde mental tenham aumentado nos últimos anos, o campo de estudo continua desconectado, desigual e isolado, retardando os progressos urgentes para a abordagem dos impactos da mudança climática na saúde mental e a compreensão dos benefícios da ação climática para a saúde mental.

Connecting Climate Minds (CCM) é uma iniciativa financiada pela Wellcome que visa promover um campo colaborativo e transdisciplinar sobre mudanças climáticas e saúde mental com uma visão clara e alinhada. Durante o último ano, reunimos especialistas de todas as disciplinas, setores e países para desenvolver agendas de pesquisa e ação regionais e globais. Essas agendas estabeleceram: 1) uma abordagem investigativa para identificar, compreender e atender as necessidades das pessoas que experimentam o fardo da crise climática em sua saúde mental; e 2) prioridades para pesquisa e tradução de evidências de ações em políticas e práticas.

O presente relatório apresenta uma proposta de agenda de pesquisa e ação para as mudanças climáticas e a saúde mental na América Latina e no Caribe (ALC).

Uma revisão de escopo realizada como passo fundamental deste projeto encontrou estudos limitados na ALC que investigam o impacto das mudanças climáticas na saúde mental. As pesquisas existentes fornecem insights importantes baseadas nos contextos culturais e históricos do clima e da saúde mental na ALC.^{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} No entanto, muitos estudos foram realizados após grandes desastres ciclônicos e carecem de uma consideração mais ampla do impacto da crise climática na saúde mental. A literatura conhecida aborda principalmente cenários negativos para a saúde mental decorrentes de eventos climáticos extremos agudos nos contextos de a) gravidade do trauma/perda testemunhado/presenciado e b) de vulnerabilidades socioeconômicas subjacentes.^{2, 3, 4}

Na ALC, o risco de enfrentar adversidades à saúde mental relacionados com o clima varia entre áreas geográficas, dados demográficos pessoais e características socioculturais. No entanto, os povos indígenas, as minorias étnicas, a economia costeira e as comunidades agrícolas, as mulheres, as crianças, os jovens, os idosos, as pessoas com deficiência e as pessoas com adversidades à saúde mental pré-existent parecem mais vulneráveis às adversidades de saúde mental relacionados com o clima. Embora seja necessária mais pesquisas, os medicamentos tradicionais e as respostas comunitárias — incluindo por parte de grupos religiosos e daqueles que confiam num poder para além da humanidade — podem ser ferramentas úteis para enfrentar os desafios de saúde mental e bem-estar associados às mudanças climáticas na região.

Os temas de pesquisa prioritários para a região abrangem inúmeras áreas, incluindo:

- Compreender e definir conceitos de vulnerabilidade e resiliência da saúde mental autopercebidas relacionadas com o clima;
- Definir os principais termos de diagnóstico, como eco-ansiedade;

- Quantificar o fardo “adicional” de saúde mental associado à crise climática;
- As perturbações nos caminhos de cuidados de saúde mental que ocorrem secundariamente à crise climática; e
- Compreender os caminhos e mecanismos pelos quais a crise climática está afetando a saúde mental na ALC, incluindo:
 - Até que ponto as modulações dos indicadores socioeconômicos gerais ou de desenvolvimento humano relacionadas com a crise climática dão origem a adversidades à saúde mental ou distorções do bem-estar mental;
 - O impacto do calor nos resultados de saúde mental, incluindo estados depressivos e incidência de lesões autoprovocadas ou morte por suicídio;
 - Distorção do ritmo circadiano relacionada com o clima devido a mudanças nas condições de vida e de sono, e a incidência concomitante de problemas de bem-estar mental ou efeitos sobre a saúde mental em crianças e povos indígenas (estes foram os grupos identificados como sendo vulneráveis a esta questão, mas é provável que é muito mais difundido); e
 - Mudanças no cortisol relacionadas ao clima e a ocorrência de estresse.

A operacionalização de uma agenda de pesquisa na ALC exigirá pesquisas respeitadas, contextualmente relevantes e culturalmente apropriadas. As abordagens participativas à pesquisa serão cruciais, com o envolvimento dos povos indígenas, dos jovens e das organizações da sociedade civil (especialmente onde as estruturas formais de governação nacional são frágeis). O envolvimento com membros leigos da comunidade como cocriadores, implementadores e disseminadores da pesquisa será importante para garantir um sentimento de pertencimento, controle e propósito para a ação em saúde mental relacionada com o clima, especialmente entre os jovens.

Esperamos que esta agenda ajude a concentrar os esforços de financiamento, políticas e práticas das comunidades que trabalham em prol de um futuro onde ninguém seja impedido pelas adversidades à saúde mental relacionados ao clima.

Referência rápida: Principais conclusões

1. O impacto dos eventos climáticos na saúde mental e no bem-estar na ALC pode ser agravado por condições políticas, culturais, sociais e econômicas.
2. O problema varia conforme a geografia, a demografia e as características socioculturais. Os povos indígenas, as minorias étnicas, a economia costeira e as comunidades agrícolas, as mulheres, as crianças, os jovens, os idosos, as pessoas com deficiência e aqueles com adversidades à saúde mental pré-existentes foram identificados como os mais vulneráveis às perturbações na saúde mental e no bem-estar e às possíveis novas adversidades à saúde mental relacionados ao clima.
3. Os eventos climáticos adversos podem desencadear eventos que levam a desafios socioeconômicos que afetam negativamente o bem-estar mental (por exemplo, a seca pode levar à perda da segurança alimentar, que, por sua vez, pode resultar em migração forçada e deslocamento, gerando vulnerabilidades relacionadas à pobreza, o que pode levar à distorção do bem-estar mental). Também é possível que fatores biológicos, sociais e psicológicos interdependentes e encadeados secundários à exposição a eventos climáticos adversos possam agravar as adversidades à saúde mental existentes. Essas perturbações podem surgir devido a alterações nos caminhos de cuidado.
4. É igualmente importante identificar subgrupos populacionais que experimentam maior vulnerabilidade quanto as adversidades à saúde mental causados por eventos climáticos adversos, e inversamente aqueles que experimentam resistência a esses efeitos. Portanto, há necessidade de pesquisa bidirecional. Este trabalho exigirá o uso de métodos mistos e deverá procurar estabelecer definições e critérios clínicos para as condições da saúde mental relacionadas à mudança climática (por exemplo, eco-ansiedade), e deverá também procurar validar ferramentas clínicas da própria ALC. O progresso da pesquisa na região será afetado pela atual falta de sistemas de vigilância de saúde mental; portanto, a pesquisa deve incluir elementos de desenvolvimento humano (por exemplo, força de trabalho) e de infraestrutura.
5. A sensibilização cultural e a adequação são essenciais para a realização bem-sucedida de pesquisas sobre clima e saúde mental na ALC. Os pesquisadores devem observar que os povos indígenas na ALC são um grupo diversificado; nem todos os povos indígenas têm uma visão de mundo espiritual.
6. A pesquisa colaborativa (multissetorial e interdisciplinar) será valiosa em ambientes com recursos limitados dentro da ALC.
7. Parcerias entre os financiadores da pesquisa e a sociedade civil na ALC podem ser úteis quando as estruturas formais de governança nacional são frágeis.
8. O envolvimento dos jovens como cocriadores, implementadores e disseminadores da pesquisa é essencial.
9. As respostas criadas pela comunidade podem gerar soluções úteis para enfrentar as adversidades ao bem-estar e à saúde mental decorrentes das mudanças climáticas.

Introdução

Context

As mudanças climáticas e a saúde mental são dois dos nossos maiores desafios globais, e a sensibilização da interseção entre a saúde mental e a crise climática cresceu rapidamente nos últimos anos.¹² As mudanças climáticas agravam as adversidades à saúde mental ao aumentar a exposição ao calor excessivo e aos traumas causados por eventos meteorológicos extremos,¹³ desestabilizando as condições necessárias para uma boa saúde mental e o bem-estar (por exemplo, insegurança hídrica e alimentar, migração forçada, poluição atmosférica, destruição de ambientes ricos),¹³ comprometendo o acesso à saúde¹⁴, e aumentando o sofrimento psicológico através da sensibilização das ameaças climáticas e à ação climática ineficiente.¹⁵ As pessoas que vivem com adversidades à saúde mental também são particularmente vulneráveis aos fatores estressantes da crise climática, como o risco aumentado de estresse térmico e de morte durante ondas de calor.^{16,17,18}

Em resposta ao crescente impacto da crise climática na saúde mental, a pesquisa no campo do clima e da saúde mental evoluiu rapidamente. No entanto, em muitas regiões existem importantes lacunas de evidências, como o fardo na saúde mental atribuível às mudanças climáticas, os caminhos e mecanismos subjacentes a esses impactos, os co-benefícios da ação climática para a saúde mental e as melhores intervenções ou soluções para dar apoio à saúde mental em uma mudança climática. A pesquisa sobre mudanças climáticas e saúde mental continua, infelizmente, dividida entre disciplinas, setores e geografias, e está focada de maneira desigual em certos assuntos e regiões globais.¹⁹ Além disso, a tomada de decisão isolada retarda a tradução da evidência para a ação alinhada com as políticas e práticas de saúde mental e climática.^{20,21} Uma agenda mais inclusiva e conectada é urgentemente necessária a fim de gerar evidências para realmente entender, monitorar e responder às interconexões entre a mudança climática e a saúde mental.

Connecting Climate Minds

Connecting Climate Minds (CCM) é um projeto financiado pela Wellcome, lançado em 2023, para desenvolver uma agenda inclusiva de pesquisa e ação em mudanças climáticas e saúde mental. O projeto tem dois objetivos principais interligados. O primeiro se trata de desenvolver uma agenda inclusiva e alinhada para a pesquisa e ação baseada nas necessidades daqueles com experiência vivida de adversidades à saúde mental no contexto da mudança climática, para nortear o campo nos próximos anos. O segundo é impulsionar o desenvolvimento das comunidades de prática voltada para a mudança climática e saúde mental nas sete regiões globais (definidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), equipadas para implementar essa agenda. Visamos combinar os pontos fortes da perspectiva global e do enfoque regional, além dos de diversas disciplinas, em uma visão compartilhada que possa assegurar que a pesquisa seja eficaz na identificação das lacunas de evidência e informar sobre as mudanças na prática e nas políticas relacionadas à mudança climática e à saúde mental.

Ao reunir especialistas de diversas disciplinas, setores e países, a equipe do CCM facilitou o desenvolvimento de uma pesquisa baseada em experiências vividas e uma agenda de ação no campo das mudanças climáticas e da saúde mental na América Latina e no Caribe (ALC).

Objetivos da agenda de pesquisa e ação

A agenda de pesquisa e ação foi projetada para concentrar os esforços futuros para ajudar aqueles que estão presenciando ou vão presenciar as adversidades à saúde mental agravados pelas mudanças climáticas. O objetivo é apoiar aqueles que já respondem a esses desafios — através de comunidades, pesquisa, políticas e práticas — desenvolvendo um campo mais conectado e colaborativo sobre mudança climática e saúde mental. Ele também visa capacitar especialistas de todas as disciplinas e setores para se juntar e fazer progressos nessa área, identificando claramente as prioridades e promovendo um campo de estudo mais inclusivo e transdisciplinar.

A agenda aborda essas metas através de três objetivos centrais, que são:

1. Identificar prioridades de pesquisa que possam orientar a ação para atender as necessidades das pessoas que experimentam e respondem aos impactos da mudança climática na saúde mental na África Subsaariana.
2. Identificar o que é necessário para realizar adequadamente pesquisas e traduzir evidências de ação em políticas e práticas na África Subsaariana.
3. Desenvolver a compreensão entre pesquisadores, financiadores e especialistas em políticas de todas as disciplinas e setores sobre o seu papel na promoção da pesquisa sobre mudanças climáticas e saúde mental e equipá-los com prioridades claras e executáveis.

A agenda regional será integrado com outros seis para dar base a uma **agenda global de pesquisa e ação** sobre mudanças climáticas e saúde mental. Isso garantirá que os esforços globais de pesquisa e os investimentos em mudanças climáticas e saúde mental se baseiem em prioridades de nível regional. É importante ressaltar que a agenda global também integrará insights de agenda desenvolvidos com e para alguns dos grupos mais afetados globalmente, nomeadamente povos indígenas, jovens e pequenos agricultores e pescadores.

Uso dos termos de mudança climática e saúde mental

Mudanças climáticas e saúde mental e sua interseção são temas complexos e abrangentes. Para os fins desta agenda, definimos o escopo desses termos da seguinte forma.

Pelas **adversidades à saúde mental**, entendemos pensamentos, sentimentos e comportamentos que afetam a capacidade de uma pessoa de funcionar em uma ou mais áreas da vida e que, muitas vezes, envolvem níveis significativos de sofrimento psicológico. Isso inclui, mas não se limita a, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, psicose, pensamentos suicidas e uso indevido de substâncias.

Por **experiências dos efeitos da mudança climática**, queremos dizer: 1) presenciar impactos diretos dos riscos climáticos, como ondas de calor mais frequentes e intensas, incêndios/queimadas florestais, secas, enchentes ou tempestades (por exemplo, tufões, furacões, ciclones) e 2) presenciar perturbações nos determinantes sociais e ambientais da boa saúde mental, por exemplo, ser forçado a mudar de casa, não ter acesso a alimentos ou água, perder o sustento ou a terra natal, ou perturbar as práticas culturais, como resultado das mudanças climáticas.

As adversidades à saúde mental no contexto da mudança climática incluem:

- Como a mudança climática pode levar ao agravamento das adversidades à saúde mental pré-existentes.
- Como a mudança climática pode contribuir para a prevalência ou o impacto das adversidades à saúde mental já existentes.
- Como a mudança climática pode afetar o acesso ou a eficácia do tratamento para pessoas com adversidades à saúde mental.
- Como a mudança climática pode levar a novas adversidades à saúde mental.

A convocação do CCM oferece uma oportunidade importante de desenvolvermos a compreensão de diversas perspectivas, enquadramentos e terminologias na ALC, que também procuramos refletir na agenda de pesquisa e ação.

Histórico do Connecting Climate Minds

Comunidade de Prática Regional

O projeto CCM na ALC é liderado por uma Equipe da Comunidade Regional (RCT), responsável por reunir diversos conhecimentos especializados em toda a região e desenvolver a capacidade regional de criar e implementar a agenda de pesquisa e ação. A estrutura da RCT está descrita abaixo.

Coordenador da Comunidade Regional (RCC)

Propósito: Responsável pelo desenvolvimento e pela execução das atividades do projeto na região, incluindo a convocação e o apoio a uma comunidade regional de diversas especialidades.

Membros:

Líder da Equipe do Projeto: **Embaixadora Gillian Bristol**, Centro Latino-Americano do Caribe (LACC), Vice-Chancelaria, UWI Mona, Jamaica

Pesquisador Líder/Gerente de Projeto: **Dra. Sandeep Maharaj**, Campus de St. Augustine da UWI,

Consultor Técnico: **Dra. Natalie Greaves**, UWI Cave Hill

Assistente de Pesquisa: **Dra. Shamjeet Singh**, UWI St. Augustine

Assistente de Pesquisa: **Dra. Satish Jankie**, The UWI St. Augustine

Comunicação/Administração: **Sra. Lina Torres Maestre**

Coordenadora: **Sra. Chandika Ganesh**

Assistente: **Sra. Jacinth Seemungal**

Co-coordenadores

Propósito: Oferecer mais amplitude de especialização em diferentes disciplinas e países (ou seja, organizações que abrangem especialização em clima, em neurociência do stress e saúde mental, em diferentes setores), fornecer aconselhamento técnico e revisão e apoiar a execução de projetos.

Membros:

Professor Enrique Falceto De Barros, Diretor da WONCA (Organização Mundial de Médicos de Família) Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGECI) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Sr. Marcos Williamson, Pesquisador Educacional e Diretor do Centro de Informações Ambientais da Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), Nicarágua

Dra. Martha Rosa Munoz, Diretora da FLACSO Cuba - A Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), Cuba

Dra. Fresia Hernandez, Diretora Nacional do Programa de Psicologia Clínica e da Saúde do Tecnológico de Monterrey (TEC), México

Dra. Dassaëve Brice, EarthMedic e EarthNurse Haiti

Dra. Clemencia Ramirez, Consultora Independente, Organização Internacional de Migração (IMO)

Co-coordenadores Assistentes/Facilitadores de Diálogos:

Dra. Tatiana Camargo, Centro Brasileiro de Saúde Planetária da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Dra. Raquel Santiago, Planetary Health (PH) Brasil, IEA/USP

Professor Jonathan Sherin, The Healthy Brains Global Initiative

Grupo Consultivo de Experiência Vivida (LEAG)

Propósito: Conselho deliberativo de especialistas com experiência vivida em desafios de saúde mental no contexto da mudança climática e/ou pertencentes a grupos populacionais vulneráveis e que convivem com riscos climáticos. Com base em sua experiência e conhecimento exclusivos, os LEAGs fornecem perspectivas e orientações vitais, centradas na comunidade que informam a abordagem abrangente e os resultados do projeto.

Membros:

Srta. Vashti Burrows, Bahamas

Srta. Gloria Blaise, Haiti

Srta. Raquel Tupinambá, Conselho Indígena Tupinambá do Baixo Tapajós/Amazônia,

Sr. Norton Chavarria, Comunidade Karata, Nicarágua

Jovens Embaixadores (YAs)

Propósito: Consultores jovens (de 18 a 29 anos) com experiência vivida nos desafios de saúde mental no contexto da mudança climática e/ou pertencentes a grupos populacionais vulneráveis e que vivem com riscos climáticos. Os YAs trazem perspectivas únicas, centradas nos jovens, para o desenvolvimento e a implementação das atividades do projeto.

Membros:

Srta. Ana Gabriela Mejia - Ecuador

Sr. Harvey Vijay Sharma - Guyana

Metodologia

- Produzimos essa agenda de pesquisa e ação através de uma metodologia robusta e inclusiva para capturar, combinar e refinar uma rica diversidade de perspectivas e, ao mesmo tempo, promover a conexão em uma crescente comunidade de prática. Dada a necessidade de gerar dados descritivos sobre experiências vividas sobre um tópico relativamente novo e sensível, foi utilizada uma abordagem pragmática de métodos mistos baseada fortemente nos princípios de design de pesquisa qualitativa.
- A equipe central do CCM desenvolveu esta metodologia em consulta com as Comunidades Regionais de Prática, um Conselho Consultivo Global e a Wellcome, o que facilitou importantes mudanças iterativas na metodologia. Os métodos e materiais foram adaptados regionalmente para garantir um equilíbrio da padronização global com a adequação e flexibilidade regionais. O compartilhamento contínuo entre regiões de processos, aprendizados e desafios, foi essencial para o desenvolvimento iterativo da metodologia. O processo abrangente de desenvolvimento das agendas de pesquisa e ação regionais, é mostrado a seguir.



Figura 1: Metodologia de desenvolvimento da agenda de pesquisa e ação

Escopo pré-diálogo

O escopo global e o enquadramento foram realizados antes da realização de pesquisas nas regiões dos ODS no projeto CCM. Durante o escopo global, a equipe central do CCM realizou:

- Uma análise de escopo em nível global de revisões atuais, dos principais documentos e dos relatórios de políticas relacionados com as mudanças climáticas e a saúde mental;
- Um mapeamento das categorias de pesquisa abrangidas e utilizadas para estruturar revisões anteriores do campo; e
- Um segundo mapeamento das recomendações de ação sobre mudanças climáticas e saúde mental propostas por relatórios escritos para informar políticas e práticas.

Eles então usaram esses resultados para definir a linha de investigação para o diálogo e a agenda de pesquisa, para garantir o alinhamento com o campo atual, respondendo às importantes lacunas.

Pesquisa de escopo realizada com a ALC

- Além do acima mencionado, o líder da equipe de projeto e pesquisador principal do RCC da ALC, se engajou com especialistas em experiência vivida e consultores especializados no campo através de discussões dos principais informantes para garantir que a produção da agenda de pesquisa fosse adequadamente baseada em uma compreensão das principais necessidades de experiência vivida e políticas emergentes na região.
- O RCoP da ALC também realizou uma revisão de escopo para resumir as evidências relacionadas a eventos/ameaças climáticas e os resultados associados à saúde mental, incluindo mecanismos subjacentes específicos para a região.
- A literatura revisada identificou lacunas no conhecimento e informações contextuais sobre clima e saúde mental na ALC, (estes são fornecidos no Apêndice 1, enquanto a metodologia da revisão, diagramas PRISMA e resumo dos documentos revisados são apresentados no Apêndice 2).
- A equipe da ALC também distribuiu uma **pesquisa online** antes do Diálogo 1 (**pesquisa pré-diálogo**) para obter percepções sobre impactos climáticos regionais, impactos de saúde mental relacionados ao clima e prioridades de pesquisa.
- Os resultados de todas as atividades de escopo específicas, globais e regionais, foram então combinados para finalizar o projeto de diálogos regionalmente relevantes e culturalmente apropriados.

Metodologia do diálogo

- Os especialistas de diferentes disciplinas e setores foram deliberadamente selecionados e recrutados através de bolas de neve através de redes regionais de co-convocação, para comparecer de dois diálogos virtuais (3 horas cada).ⁱ
- O quadro para os diálogos foi concebido pela equipa global e ajustado pelo RCoP da ALC para aumentar a pertinência cultural e facilidade de utilização entre as diversas línguas e capacidades tecnológicas da região (consulte o Apêndice 3 para agendas de diálogo).
- Os diálogos foram facilitados por uma unidade de diálogo composta por membros da ALC do RCoP, que são os próprios pesquisadores, formuladores de políticas e especialistas em experiências vividas, juntamente com colegas da equipe central do CCM e do Centro do Clima da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.
- Os membros da unidade de diálogo apresentaram-se em sessões plenárias e serviram como facilitadores de discussão, tomadores de notas ou pesquisadores observadores não participantes nas salas de discussão, contribuindo assim para a produção, coleta e análise de dados.
- O primeiro diálogo identificou perigos e riscos climáticos/saúde mental, mapeou populações vulneráveis e reuniu insights sobre necessidades regionais percebidas e presenciadas e prioridades da pesquisa.
- O segundo diálogo recolheu feedback sobre as prioridades de pesquisa (do Diálogo 1) e identificou pensamentos e recomendações sobre a realização de pesquisas e a tradução de evidências para políticas e práticas na ALC. Também explorou a diversidade das perspectivas regionais e a compreensão dos principais conceitos relevantes.

ⁱ Bola de neve se refere aos participantes em potencial que identificam e indicam outros participantes adequados.

- Os dados gerados nos diálogos incluíram: Chats do Zoom, anotações feitas por dedicados tomadores de notas, transcrições das discussões de sala de discussão/discussões plenárias e anotações do Google Jamboard escritas pelos participantes (apenas no Diálogo 2).

Metodologia da pesquisa

- Distribuímos uma **pesquisa online, pós-diálogo**, após o Diálogo 2 para verificar as conclusões, obter uma segunda rodada de feedback sobre as prioridades de pesquisa e identificar quaisquer métodos, métricas e conjuntos de dados relevantes para abordar essas prioridades.

Metodologia de análise

- **Categorias de pesquisa:** Como descrito anteriormente, o Centro de Cuidados com o Clima realizou um exercício global de paisagismo de revisões relevantes existentes de mudança climática e saúde mental e identificou quatro grandes categorias de pesquisa como áreas de necessidade essencial, para mais trabalho a nível mundial. Essa estrutura foi usada como base para estruturar as discussões dentro dos diálogos para gerar prioridades de pesquisa e formou a estrutura de codificação global para análise.
- **Seleção de temas de pesquisa prioritários:** Os participantes do Diálogo 1 foram guiados através de uma discussão semiestruturada explorando suas opiniões sobre as consequências emergentes e prováveis para a saúde mental dos riscos climáticos relevantes regionalmente, presentes e futuros, e oportunidades para benefícios de ação em saúde mental. Os participantes então conceberam possíveis temas de pesquisa, com base em onde a evidência poderia ser útil, para informar/impactar políticas e práticas (consulte o Apêndice 4 para critérios para seleção de temas de pesquisa prioritários).
- **Análise:** Os dados do diálogo (transcrições das salas de discussão e anotações) foram analisados com o uso de um método de estrutura temática híbrida — uma abordagem baseada em matriz que permite que os pesquisadores qualitativos façam uma análise profunda dos dados (por exemplo, transcrições e anotações escritas) para ajudar na identificação de padrões recorrentes nos dados.
 - A equipe de analistas (consulte o Apêndice 5 para descrição) utilizou um quadro de codificação para codificar transcrições de diálogo (consulte o Apêndice 6).
 - Resumos diferenciados dos padrões identificados, foram então produzidos em alinhamento com as quatro categorias gerais, identificadas a partir do exercício global de paisagismo e resumidos em uma matriz de tabela.
 - As principais citações extraídas das notas e transcrições das salas de discussões são apresentadas mais adiante neste relatório como evidência contextual para apoiar os temas.
- **Esboço de temas de pesquisa prioritários:** Os resumos diferenciados, mencionados acima, foram usados para elaborar uma lista de temas de pesquisa prioritários, com base na triangulação entre notas de discussão, transcrições, alcance pré-diálogo e consulta de peritos.
- **Aprimoramento dos temas de pesquisa prioritários:** Temas de pesquisa (na forma de perguntas) foram compartilhados com os participantes do Diálogo 2, que deram feedback em resposta às seguintes pedidos:

“Esse é um tópico de pesquisa importante para a ALC? Alguma coisa deveria ser adicionada ou retirada?” (Os pedidos foram apresentados em linguagem leiga para aumentar a acessibilidade para todos os participantes). Os temas de pesquisa foram então refinados em resposta a esse feedback e compartilhados com os participantes do diálogo para comentários em uma pesquisa

pós-diálogo como uma forma de verificação dos participantes. Na introdução da pesquisa, os participantes foram agradecidos (culturalmente necessários) e depois convidados a fazer as mudanças necessárias. A pesquisa pós-diálogo também foi distribuído a uma ampla amostra de peritos que não participaram no diálogo com o pedido: *Há algo que você gostaria de alterar, remover ou adicionar a este tema de pesquisa?* Todos os participantes na pesquisa pós-diálogo tiveram a opção de sugerir temas de pesquisa adicionais.

- **Finalização dos temas de pesquisa prioritários:** Uma lista final de temas de pesquisa prioritários foi gerada com base na incorporação do feedback da pesquisa pós-diálogo, na consulta à ALC do RCoP, aos especialistas regionais, à equipe principal do CCM, ao Conselho de Consulta Global e a Wellcome.

Participantes

Os participantes do diálogo eram um grupo diversificado em termos de distribuição geográfica, gênero, setor e disciplina. Todos os participantes foram convidados para os dois diálogos, mas em alguns casos os participantes não puderam comparecer em ambos.

No total, 45 participantes compareceram ao Diálogo 1 e 30 participantes compareceram ao Diálogo 2. As tabelas abaixo apresentam um detalhamento das características dos participantes.

Distribuição geográfica

País	Diálogo 1		Diálogo 2	
	Número de participantes	Percentual	Número de participantes	Percentual
Bahamas	1	2,5%	1	3,80%
Barbados	1	2,5%	1	3,80%
Bolívia (Estado Plurinacional da)	1	2,5%	0	0%
Brasil	4	11%	5	19%
Chile	2	5%	0	0%
Costa Rica	1	2,5%	1	3,80%
Equador	1	2,5%	0	0%
Granada	2	5%	0	0%
Guatemala	1	2,5%	1	3,80%
Haiti	4	11%	5	19%
Honduras	3	8%	0	0%

Jamaica	3	8%	2	8%
México	3	8%	1	3,80%
Nicaragua	3	8%	2	8%
Santa Lúcia	1	2,5%	0	0%
Trindade e Tobago	5	13%	7	27%
Estados Unidos da América	2	5%	0	0%

Especialização

	Diálogo 1		Diálogo 2	
Especialização	Número de participantes	Percentual	Número de participantes	Percentual
Mudança Climática	12	21%	7	19%
Saúde Mental	13	23%	11	29,7%
Saúde	18	31,5%	14	37,8%
Outros	14	24,5%	5	13,5%
Não sei/Prefiro não dizer	0	0%	0	0%

Modalidade

	Diálogo 1		Diálogo 2	
Modalidade	Número de participantes	Percentual	Número de participantes	Percentual
Ativismo	5	4,5%	4	5%
Comunidade	13	12%	9	11%
Educação	21	19%	17	21%
Especialista através da experiência própria	5	4,5%	4	5%
Financiamento	1	1%	0	0%

Serviço de saúde	16	14,5%	12	15%
Organização Não-governamental	13	12%	9	11%
Política	4	3.5%	4	5%
Pesquisa	25	23%	19	24%
Outros	7	6%	2	3%

Gênero

	Diálogo 1		Diálogo 2	
Gênero	Número de participantes	Percentual	Número de participantes	Percentual
Homens	8	36%	12	46%
Mulheres	13	59%	14	54%
Não-binário	1	5%	0	0%
Não sei/Prefiro não dizer	8	36%	12	46%

Participantes da pesquisa:ⁱⁱ

Pesquisa pré-diálogo: 76

Pesquisa pós-diálogo: 6

Ética, coleta e armazenamento de dados

Este estudo foi revisado e recebeu um parecer ético favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do Imperial College (título do estudo: “Diálogos Globais para estabelecer uma agenda de pesquisa acionável e construir uma comunidade de prática em mudanças climáticas e saúde mental”; Número de identificação do estudo: 6522690). Além disso, o protocolo do estudo, com as adaptações locais necessárias, foi revisado e aprovado pelo Conselho de Revisão Institucional da University of the West Indies, St Augustine [CREC-SA. 2298/08/2023].

Os detalhes sobre a coleta e armazenamento de dados podem ser encontrados no Apêndice 7.

ⁱⁱ Observe que os números são aproximados e não consideram respostas duplicadas ou incompletas.

Estado atual e necessidades emergentes para as mudanças climáticas e saúde mental na América Latina e no Caribe

À medida que a crise climática se intensifica, mais pessoas em todo o mundo estão experimentando consequências relacionadas à saúde mental. No entanto, a base de evidências atual não capta completamente essas experiências. Para desenvolver temas de pesquisa que, em última análise, atendam às necessidades daqueles que experimentam e respondem às interligações entre mudanças climáticas e saúde mental, é vital saber: 1) o que as pessoas de diferentes históricos, contextos e setores — especialmente aqueles com experiências vividas de adversidades à saúde mental no contexto da crise climática — relatam como suas experiências, necessidades e resiliência, e 2) que evidências as pessoas que tomam decisões e tomam ações no terreno precisam para responder adequadamente?

Esta seção descreve o contexto da agenda de pesquisa, explorando os perigos climáticos que a região enfrenta, o estado atual das evidências sobre saúde mental e mudanças climáticas na ALC, e principais insights e necessidades emergentes da região.

Perigos climáticos na ALCⁱⁱⁱ

A América Latina e o Caribe (ALC) enfrentam um aumento na frequência e na gravidade de uma série de riscos climáticos, incluindo os seguintes, modelados para aproximadamente 2030 em comparação com a linha de base histórica (geralmente 1986-2005): ^{22, 23, iv}

- **Temperaturas extremas**, particularmente nas regiões tropicais da América do Sul, América Central e Cuba e nas regiões costeiras do México (com variação entre modelos climáticos; confiança média); ^v
- **Secas e incêndios florestais** no norte da Argentina, nas regiões mais populosas do Brasil e em áreas do México (confiança alta);
- **Eventos de precipitação intensa e inundações**, com intensidade e frequência de precipitação extrema e inundações pluviais projetadas para aumentar na América do Sul (confiança média a alta), embora a América Central e as Ilhas do Caribe sejam mais propensas a experimentar um declínio na precipitação média (baixa confiança);
- **Aumento do nível do mar**, contribuindo para o aumento das inundações costeiras em áreas baixas e para o recuo da linha costeira ao longo da maioria das costas arenosas, particularmente em torno da América Central e do Sul (confiança elevada); e
- **Ciclones tropicais**, com um aumento médio projetado de cerca de 3%.

ⁱⁱⁱ Informações baseadas no exercício de mapeamento e projeções do Centro do Clima da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (métodos detalhados no Apêndice 8).

^{iv} Projeções futuras são baseadas em um cenário intermediário de emissões rodoviárias (SSP2-4.5 Caminho Sócio-econômico compartilhado) do conjunto multimodelo CMIP6 fornecido no IPCC, 2021.

^v No IPCC e em outras fontes importantes de projeções climáticas, os níveis de confiança são apresentados numa escala de baixo, médio e alto. A classificação refere-se à robustez das provas disponíveis e à concordância entre os modelos climáticos.

Mudança climática e saúde mental na América Latina e no Caribe:

Resumo da revisão de escopo

Uma revisão de escopo realizada como passo fundamental deste projeto encontrou estudos limitados na ALC, que investigam o impacto das mudanças climáticas na saúde mental. As pesquisas existentes fornecem insights baseadas nos contextos culturais e históricos do clima e da saúde mental na ALC.²⁻¹¹ No entanto, muitos estudos foram realizados após grandes desastres ciclônicos e carecem de uma consideração mais ampla do impacto da crise climática na saúde mental. A literatura identificada centra-se principalmente nos resultados negativos para a saúde mental decorrentes de eventos climáticos extremos agudos no contexto de: a) a gravidade do trauma/perda testemunhado/presenciado, e b) vulnerabilidades socioeconômicas subjacentes.^{2,3,4} Portanto, há necessidade de uma agenda de pesquisa e ação que explore todo o espectro de eventos climáticos agudos e correntes que afetam a região. A influência positiva dos espaços verdes também merece mais atenção.⁸

A revisão de escopo sugeriu ainda que uma agenda de pesquisa e ação para a ALC deveria ser discutida e investigada de acordo com os padrões de migração e outros fatores socio-políticos e econômicos que podem influenciar ou mediar a relação entre a mudança climática e a saúde mental.

Resumo dos resultados dos diálogos e pesquisas

Esta subseção apresenta as conclusões dos diálogos e pesquisas descritos anteriormente relativos às percepções de quatro categorias de pesquisa abrangentes, conforme listado abaixo. Estas categorias foram identificadas como áreas com necessidade essencial de trabalho adicional em nível global e que mapeiam o espaço de pesquisa sobre clima e saúde mental em alto nível, com base em uma revisão inicial da literatura. Os temas de pesquisa prioritários na seção a seguir também estão organizados dentro dessas quatro categorias.

- **Impactos, riscos e grupos vulneráveis:** melhorar a nossa compreensão do quanto a saúde mental é afetada pelas mudanças climáticas e quem é mais afetado. Por exemplo: quais resultados de saúde mental são afetados ou estão em risco; a prevalência, a gravidade, os custos financeiros e sociais desses impactos; e quem está mais vulnerável a esses impactos.
- **Caminhos e mecanismos:** melhorar a nossa compreensão de como a mudança climática afeta a saúde mental e, em particular, se existem fatores específicos da mudança climática que aumentam os riscos para a saúde mental ou criam novas experiências aos desafios de saúde mental. Isso inclui considerar caminhos e mecanismos biológicos, psicológicos, sociais ou ambientais.
- **Benefícios da ação climática para a saúde mental (adaptação e mitigação):** compreender e quantificar quando e como as ações de adaptação e mitigação climática, entre setores, também podem ter benefícios mútuos para a saúde mental.
- **Intervenções/soluções de saúde mental no contexto da mudança climática:** identificar as intervenções/soluções mais eficazes para apoiar a saúde mental no contexto da mudança climática, em diversos setores. Isto engloba o fornecimento de apoio a pessoas que já estão sofrendo impactos negativos na saúde mental e a redução do risco ou da gravidade de futuros impactos negativos na saúde mental.

Tabela 2: Conclusões de pesquisa relacionados às necessidades regionais emergentes de saúde mental no contexto das mudanças climáticas na ALC.

Categoria de pesquisa	Síntese abrangente das conclusões para a região da ALC
impactos, riscos e grupos vulneráveis	Riscos variados e vulnerabilidades amplas: Na ALC, o risco de enfrentar desafios de saúde mental relacionadas com o clima variou entre áreas geográficas, dados demográficos pessoais e características socioculturais. Os seguintes grupos foram identificados como sendo mais vulneráveis a distorções de bem-estar mental relacionadas ao clima e possíveis novos desafios de saúde mental: • Crianças • Comunidades econômicas costeiras e agrícolas • Pessoas com deficiência • Minorias étnicas • Grupos indígenas • Pessoas com desafios de saúde mental pré-existent • Mulheres • Jovens É igualmente importante identificar subgrupos populacionais que apresentam maior vulnerabilidade às adversidades à saúde mental causadas por eventos climáticos adversos e, inversamente, aqueles que apresentam resistência a esses efeitos. Portanto, há necessidade de pesquisa bidirecional explorando as duas perspectivas de vulnerabilidade e resiliência. <i>Conceito importante de refinamento:</i> Os povos indígenas devem ser vistos como grupos heterogêneos. Não se deve presumir que todos os grupos indígenas têm uma conexão espiritual. Comentários sobre metodologia, métricas e dados existentes: Os métodos de pesquisa devem tentar definir o fardo “adicional” de saúde mental associada às mudanças climáticas. Faltam dados sobre o fardo existente de saúde mental não relacionada ao clima em algumas partes da ALC; portanto, estudos de prevalência podem ser necessários, juntamente com sistemas de vigilância, monitoramento e avaliação para estabelecer linhas de base e monitorar tendências.
Caminhos e mecanismos	Caminhos biológicos, sociais e econômicos complexos e interligados: Os eventos climáticos adversos podem funcionar como desencadeadores primários de uma cascata de eventos que conduzem a resultados socioeconômicos adversos que podem ter um impacto negativo no bem-estar mental (por exemplo, a seca pode levar à perda de segurança alimentar, que pode levar à migração forçada e ao deslocamento, que pode levar a vulnerabilidades relacionadas à pobreza, que podem levar a problemas de saúde mental/bem-estar mental). Também é possível que fatores biológicos, sociais e psicológicos interdependentes e em cadeia secundários à exposição a eventos climáticos adversos possam agravar as adversidades existentes à saúde mental. Essas distorções podem surgir devido a alterações nos caminhos de cuidados.

Benefícios da ação climática na saúde mental (adaptação e mitigação)

Intervenções de saúde mental no contexto da mudança climática

Conceitos importantes de refinamento: Como fatores dentro da ALC estão ocorrendo simultaneamente e potencialmente atuando sinergicamente, qualquer agenda de pesquisa precisará ser interdisciplinar e orientada para a ação, identificando e abordando simultaneamente os mecanismos pelos quais a crise climática está impactando o bem-estar mental, seja criando ou agravando adversidades à saúde mental.

Utilização das estruturas existentes e envolvimento na defesa: Há benefícios potenciais na utilização dos mecanismos de resposta climática de catástrofe existentes para promover/proteger a saúde mental e o bem-estar mental na presença de ameaças climáticas. Estes mecanismos de resposta foram descritos como multissetoriais, bem estabelecidos e presentes nos níveis local, nacional e regional. Além disso, a ação e a esperança através da defesa foram identificados como um possível benefício da ação climática para a saúde mental; mais trabalhos são necessários nesta área, especialmente relacionados com a defesa e ação da juventude.

Ação coletiva é necessária: As respostas comunitárias, inclusive por grupos religiosos e aqueles que confiam em um poder além da humanidade, podem ser ferramentas úteis para enfrentar as adversidades ao bem-estar mental e saúde mental que ocorrem secundariamente às mudanças climáticas. É igualmente necessária uma parceria multissistêmica para enfrentar os determinantes sociais, econômicos e comerciais combinados dessas adversidades. Os participantes do diálogo também apresentaram várias ideias sobre como os cuidados de saúde mental poderiam ser fortalecidos, incluindo a garantia que os prestadores de cuidados de saúde oferecessem serviços contextualizados e relevantes para o impacto climático.

Conceitos importantes de refinamento: O fortalecimento da prestação de cuidados de saúde mental e a eliminação de estigmas das adversidades à saúde mental são questões fundamentais dentro da ALC. A pesquisa social, comportamental e organizacional que leva em consideração o clima e a saúde mental são essenciais.

Agenda de pesquisa

Temas de pesquisa prioritários

Histórico das categorias da pesquisa e dos temas de pesquisa prioritários

Esta agenda de pesquisa apresenta uma visão alinhada, para guiar os campos climáticos e de saúde mental na ALC (América Latina e Caribe). As prioridades de pesquisa foram geradas através de extensas consultas com especialistas em todas as disciplinas, setores e geografias na região e repetidas com especialistas regionais e globais. Os temas de pesquisa prioritários representam áreas nas quais investimentos de pesquisa específicos poderiam criar um quadro completo sobre impactos relacionados

ao clima nas adversidades à saúde mental, seus mecanismos e soluções em ações de saúde mental e climáticas.

Esperamos que essas perguntas sirvam de inspiração para orientar a direção da comunidade de pesquisa de prática, fornecer metas de investimento para os financiadores e focar a geração de evidências para melhor capacitar os formuladores de políticas e profissionais para atender às necessidades de saúde mental relacionadas com a mudança climática na ALC.

Tabela 3: Temas de pesquisa prioritários

Categoria de pesquisa Tema de pesquisa prioritário

1. impactos, riscos e grupos vulneráveis

- Identificar as características de pessoas vivendo em vulnerabilidade da mudança climática em populações da ALC e medir o quão afetada é a saúde mental dessas populações em decorrência destas vulnerabilidades.
- Entender como populações em vulnerabilidade climática na ALC percebem e respondem a eventos climáticos extremos e como estas percepções e repostas relacionam-se a resultados na saúde mental. *(Isto é importante para populações que talvez não vejam a mudança climática negativamente, a exemplo de pessoas com visões de mundo espirituais que percebem a mudança climática como normal ou esperada.)*
- Investigar a associação, caso haja, entre a exposição a eventos climáticos adversos e a ocorrência de adversidades à saúde mental ou mudanças no estado de bem-estar mental de alguma pessoa na ALC.
- Quantificar as adversidades na saúde mental/fardo de bem-estar atribuídos diretamente à mudança climática entre [insira população de interesse, como grupos vulneráveis identificados, por exemplo: comunidades ribeirinhas] na ALC.
- Medir a incidência/prevalência de [cite uma adversidade específica de saúde mental, por exemplo: intenções suicidas] ou a mudanças no bem-estar mental de uma pessoa, atribuíveis à mudança climática na ALC.
- Identificar os eventos climáticos associados com o maior risco de piora da saúde mental e/ou baixo bem-estar mental entre populações da ALC.
- Identificar fatores sociodemográficos que influenciem na vulnerabilidade a perda de saúde mental em decorrência da mudança climática na ALC.
- Identificar e compreender quais fatores vividos, ocorrentes conjuntamente aos eventos climáticos na ALC, aumentam as chances de adversidades na saúde mental. *(Se visto sob uma lente qualitativa, esta pergunta pode ser expandida para calcular o impacto de presenciar e responder a trauma climático agudo, perda ou luto associado ao ecossistema, violência sexual decorrente de efeitos da mudança climática e marginalização/estigma/discriminação decorrentes da pobreza originada pela mudança climática, tal como identificado nos diálogos.)*
- Identificar e avaliar as maneiras mais eficazes de recrutar e estudar populações em vulnerabilidade climática em vastas áreas da ALC para

auxiliar a coleta robusta e apropriada de dados sobre pesquisas climáticas e de saúde mental.

- Identificar e avaliar métodos culturalmente apropriados e economicamente viáveis para reunir dados de experiências concretas, que foquem na solução, sobre saúde mental relacionada ao clima na [inserir população de interesse, por exemplo: povos indígenas] afetados por [insira o evento climático, por exemplo: seca] dentro da ALC.

2. Caminhos e mecanismos

- Medir a prevalência de violência de gênero que ocorrem contra mulheres e crianças climaticamente marginalizadas (incluindo pessoas em situação de rua, migrantes ou em insegurança de moradia decorrente de eventos climáticos) na ALC e como isso afeta a saúde mental e bem-estar mental.
- Avaliar o impacto do calor na biodisponibilidade de medicamentos usados no tratamento de condições de saúde mental dentro da ALC; e na estabilidade destes medicamentos durante o armazenamento.
(Em particular, esta questão explora como o calor impacta os componentes ativos de medicamentos e como estes componentes interagem com os mecanismos fisiológicos.)
- Avaliar o impacto de mecanismos biológicos modificados-pelo-cortisol na saúde mental e bem-estar mental de pessoas impactadas por eventos climáticos adversos na ALC. *(Participantes especificamente mencionaram o efeito do estresse climático nos níveis de cortisol; efeitos em outros hormônios do estresse também podem ser dignos de pesquisa.)*
- Analisar o impacto de [insira o evento climático] no ciclo circadiano de [insira qualquer população] na ALC e os efeitos resultantes na saúde mental.
(Ciclo circadiano se refere aos ciclos fisiológicos de sono e vigília; esta questão explora os efeitos mentais de perturbações que podem ocorrer em hormônios associados devido a mudanças neste ritmo por fatores climáticos tais como calor ou deslocamento de moradia/abrigo após desastres climáticos, etc.)

3. Benefícios da ação climática na saúde mental (adaptação e mitigação)

- Identificar as intervenções mais efetivas para promover a ação climática coletiva, adaptação e mitigação climáticas de maneira que também melhore a saúde mental (por exemplo: ação coletiva em resposta a um desastre climático, ação coletiva para melhorar espaços verdes/projetos de plantio de árvores, etc.) na ALC.
- Identificar e avaliar as intervenções mais efetivas para promover defesa e agência como ferramentas para promover a resiliência climática na juventude da ALC e avaliar as implicações destas intervenções na saúde mental.
- Identificar as barreiras à sensibilização do impacto climático na saúde mental entre populações em vulnerabilidade climática na ALC.
- Identificar e avaliar atividades educativas ou de sensibilização climática, desde que culturalmente apropriadas e custeáveis, que possam melhorar

a saúde mental de populações em vulnerabilidade da mudança climática na ALC.

- Identificar mecanismos de baixo-custo para compartilhamento efetivo de informações sobre risco climático em populações vulneráveis (incluindo ambientes formais e informais de educação) na ALC; e avaliar como isso afeta a saúde mental.

(Esta pesquisa deve incluir como identificar e avaliar estruturas de compartilhamento de informações na esfera climática ou mental, por exemplo expandir sistemas de alerta de emergência em desastres.)

- Avaliar o potencial de modificar estratégias de comunicação em caso de risco de desastre existentes (que são usadas para ajudar a minimizar os efeitos mentais de desastres climáticos em regiões climaticamente vulneráveis) para endereçar os efeitos de saúde mental de ameaças climáticas, agudas e silenciosas, em regiões da ALC.
- Identificar e avaliar os mecanismos de sobrevivência de seca e/ou uso de terras usados por povos indígenas na ALC e seu potencial para minimizar o estresse mental e melhorar a saúde mental de populações afetadas pela mudança climática.
(O evento climático pode ser alterado para esta pergunta.)

4. Intervenções/soluções de saúde mental no contexto da mudança climática

- Medir o impacto da atenção plena diária ou práticas espirituais na saúde mental e bem-estar entre os [inserir uma subpopulação, por exemplo: os caribbas] na ALC em resposta a [inserir o evento climático de interesse].
- Identificar e avaliar a eficácia de plantas medicinais e sementes crioulas usadas por povos indígenas para minimizar ou reduzir as adversidades na saúde mental causadas pela mudança climática em [inserir região específica] e compreender as implicações de uma mudança climática para seu uso e disponibilidade.
- Identificar os caminhos mais efetivos para ação interdisciplinar e multissetorial para apoiar as intervenções em prol da saúde mental na ALC.
- Identificar e avaliar as políticas e mecanismos de financiamento (nos campos da saúde mental e do clima) compartilhados entre a região para apoiar pesquisas na intersecção da saúde mental e do clima na ALC.
- Compreender a) como pessoas com adversidades na saúde mental se conectam a serviços de cuidado na ALC, b) se isto muda no contexto de uma crise climática, c) se muda, como a saúde mental é afetada e d) a melhor maneira de fornecer cuidado contínuo e apropriado.

- Identificar e avaliar quais intervenções coletivas e comunitárias são mais benéficas para proteger a saúde mental e bem-estar no contexto da crise climática na ALC.
- Compreender o papel da religião e espiritualidade (enquanto se confia no material) em contextualizar/vivenciar as adversidades na saúde mental em relação à mudança climática na ALC, e como apropriadamente contar com isso no desenvolvimento de intervenções e suas implementações.
- Identificar as parcerias multissistêmicas para endereçar os determinantes que combinam o social, o econômico e o comercial nos desafios da saúde mental e/ou baixo bem-estar mental que pode estar piorando como consequência de ameaças climáticas agudas e crônicas.
(Esta questão foi incluída para salientar a necessidade de uma ação multissetorial e a nível de sistema, para investigar e endereçar o impacto da crise climática na saúde mental.)
- Compreender a natureza e a eficácia da auto-gestão e práticas de resiliência de populações indígenas, com respeito a [insira evento adverso] e [insira o efeito de interesse na saúde mental].

Agenda de ação

À medida que o campo das mudanças climáticas e da saúde mental na ALC se desenvolver e a base de evidências crescer, será crucial evitar perpetuar as adversidades existentes, incluindo: 1) desconexões entre disciplinas e entre pesquisadores e formuladores de políticas; 2) foco desigual em tópicos e geografias; e 3) tomada de decisão isolada para o clima e para a saúde mental. Esta agenda de ação estabelece uma visão compartilhada como um foco concentrado nos campos da saúde mental e da mudança climática na ALC. Isso inclui orientações sobre como melhor apoiar a crescente comunidade de prática, como traduzir evidências em ação, e os princípios que devem orientar essa abordagem. A promulgação desta agenda exigirá esforço transdisciplinar e ação coordenada em toda a pesquisa, financiamento de pesquisa, política e prática. Esta agenda de ação visa apoiar este trabalho, identificando as adversidades que devem ser abordadas, as oportunidades que podem ser exploradas e as ações prioritárias para trabalhar em direção a um campo climático e de saúde mental próspero.

Visão regional para saúde mental em uma mudança climática

Declaração de visão

Com base no exercício de visão e nas conversas nos Diálogos 1 e 2, os participantes lançaram uma visão esperançosa para um futuro onde ***através de ações corretivas coletivas, os impactos humanos sobre as mudanças climáticas sejam invertidos ou minimizados. Efeitos na saúde mental decorridos do clima são melhorados ao reduzir perigos climáticos e ao criar uma política favorável e uma infraestrutura social, o que inclui pesquisa participativa interdisciplinar e um melhor serviço de diagnóstico e tratamento para adversidades de saúde mental decorridas do clima.***

- O estado desejado de saúde mental relacionada ao clima é aquele em que:
 1. As ações políticas para proteger a saúde mental da população das ameaças climáticas são implementadas com base em evidências produzidas por uma comunidade regional de pesquisadores interdisciplinares que trabalham em colaboração entre setores da sociedade (incluindo pessoas com experiência vivida);
 2. Principais termos (por exemplo, eco-ansiedade) são claramente definidos no contexto da ALC;
 3. Critérios diagnósticos para os impactos climáticos na saúde mental são claramente estabelecidos;
 4. Existem instrumentos ou ferramentas psicométricas validados para a região;
 5. Existem caminhos responsivos para direcionar as pessoas a cuidados de saúde mental adequados em resposta a ameaças climáticas agudas e crônicas; e
 6. A prestação de cuidados de saúde mental no contexto das mudanças climáticas ocorre em paralelo com a reforma do sistema de saúde mental e a eliminação de estigmas do conceito de saúde mental na região.

Criação de um ambiente favorável para a pesquisa na interseção da mudança climática e da saúde mental

As prioridades de pesquisa identificadas só terão valor se forem adotadas. O campo do clima e da saúde mental é relativamente novo e cresce rapidamente, e agora é o momento de garantir que ele seja projetado para oferecer um futuro mentalmente mais saudável no contexto da crise climática. Em um campo que abrange várias disciplinas e setores, cada um com diferentes culturas e modos de trabalho, e sobre um tema com baixa sensibilização em muitos países, é necessário identificar e descrever o que é necessário para apoiar os esforços de desenvolvimento de capacidades. Quais princípios devem orientar este campo e quais são os desafios e oportunidades na região para criar um ambiente que permita essa pesquisa?

Esta seção apresenta uma síntese das discussões sobre o que é necessário para implementar a agenda de pesquisa e promover um ambiente favorável à pesquisa sobre mudanças climáticas e saúde mental. Estes dados são apresentados com citações que os apoiam na tabela abaixo.

Tabela 4: Criar um ambiente favorável para uma pesquisa intersetorial sobre mudança climática e saúde mental

Conceito	Resumo	Apoio às citações dos participantes*
Estado desejado	Há uma necessidade fundamental de discernir o impacto das mudanças climáticas na saúde mental, incluindo a definição de vulnerabilidade, o conceito de “impacto” e a relação com contextos sociais mais amplos. A pesquisa deve definir os estados de saúde mental relacionados ao clima, especialmente aqueles que podem ter fatores agravantes, com o desenvolvimento ou validação de ferramentas de diagnóstico. Por fim, há necessidade de pesquisas para esclarecer a organização e a prestação de serviços sustentáveis de saúde mental relacionados ou desencadeados pela crise climática. Isso exigirá abordagens de pesquisa baseadas na participação da comunidade.	<i>“Então, vejo a pesquisa como gerando uma melhor compreensão do espaço dinâmico da saúde mental em um contexto de mudança climática. Em outras palavras, acho que estamos presumindo que há alguma diferença no ambiente de saúde mental durante as crises climáticas em outros espaços. Esse parece ser um pressuposto.” – Sala de discussão em inglês 1, Diálogo 2</i> <i>“A saúde mental é bastante suja, na verdade. É muito difícil de limpar. Por exemplo, apenas eco-ansiedade... eu acho que a criação e validação de instrumentos é uma coisa, eu acho que o diagnóstico institucional... E a coisa mais difícil eu acho é o diagnóstico de eco-ansiedade que eu sei que tem uma escala, mas também não é validado. Você tem que validar. É muito cedo.” – Sala de discussão em português, Diálogo 2</i> <i>Nós precisamos que os pesquisadores acadêmicos, os epidemiologistas, os cientistas sociais, olhem para o impacto social, bem como [ininteligível] ao relacionado aos determinantes clínicos ou sociais da saúde.” – Sala de discussão em inglês 2, Diálogo 2</i>

Desafios	• Falta de consenso sobre os principais termos • Falta de ferramentas de validação • Falta, ou utilização limitada, de sistemas de vigilância ou registros de dados de saúde mental • Possível falta de compreensão de manifestações tardias de condições mentais pós-desastre, resultando em diagnósticos tardios • Financiamento	<i>“Eu acho que uma das coisas que não estamos realmente aprendendo é coisas tipo o transtorno de estresse pós-traumático, que acontece muito depois.”</i> – Sala de discussão em inglês 2, Dialogue 2 <i>Como os sintomas evoluem? Como eles se apresentam no momento do desastre, depois de um período de tempo e depois de um longo tempo?”</i> – Pesquisa pós-diálogo, região do Brasil <i>“Eu sei que os dados de suicídio são difíceis de medir. E se você está tentando fazer impactos na saúde mental ou... Não temos uma boa rede de saúde mental. Então, como alguém pode medir e ser capaz de fazer essa sobreposição”</i> – Sala de discussão, Diálogo 2 <i>“As agências de financiamento poderiam olhar para isso, porque tudo o que é dito sobre as mudanças climáticas são coisas muito a longo prazo, mas muito focadas em questões ambientais de resgate da biodiversidade, rever processos de produção de alimentos... soberania e segurança alimentar e nutricional, o que afeta diretamente, na minha opinião, a saúde mental”</i> – Sala de discussão, Diálogo 2 <i>“Qualificar os prestadores de cuidados de saúde para notificar a agência da Classificação Internacional de Doenças (ICD-11) associada às mudanças climáticas. Por exemplo, insônia devido a onda de calor: avisar ambos ICD G47”</i> – Pesquisa pós-diálogo, região do Brasil
Oportunidades e facilitadores	• Parceria com instituições existentes, como a Universidade de São Paulo ou a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para projetar e executar pesquisas em ambientes acadêmicos e não acadêmicos Aproveitar trabalho já financiado por grandes grupos internacionais em	<i>“Temos os estudantes, temos as universidades, neste caso, somos todos da academia, temos um sistema de saúde. Já temos a estrutura. Eu acho que é uma oportunidade, é um facilitador”</i> – Sala de discussão em português, diálogo 2 <i>“Eu realmente queria usar os alunos, porque os alunos, quando damos a aula, eles vieram com muita eco-ansiedade,</i>

	áreas relacionadas, como segurança alimentar, na região	com muito... Uma garota até disse: “Eu quero sair da faculdade de medicina porque vou fazer as pessoas viverem mais tempo e o planeta vai sofrer. Então, acho que vou parar de cursar medicina.” Eles estão falando muito sobre isso. Eu estava pensando mais em pesquisar sobre eles ou comunidades próximas que estão sofrendo, como no Rio Grande do Sul.” – Sala de discussão em português, Diálogo 2
Potenciais parceiros de relevância	As principais partes interessadas envolvidas na pesquisa multissetorial deveriam incluir: • Organizações da sociedade civil • Grupos de experiências vividas • Profissionais de saúde variados • Jovens	“Para isso, obviamente teríamos os parceiros acadêmicos e de pesquisa e as partes interessadas. Eles não precisam necessariamente ser parte de uma universidade. Precisamos também pensar em outras entidades que realizam pesquisas nesta área.” – Sala de discussão em inglês 2, Diálogo 2 “..... e estamos falando de ter os membros da comunidade, incluindo os jovens, como partes interessadas ou parceiros importantes, mais como parceiros do que como partes interessadas na pesquisa.” – Sala de discussão em inglês 1, Diálogo 2 “É uma coisa multidisciplinar, eu acho. Professores de outras instituições, porque, na verdade, há pessoas mais preparadas em outros lugares, mais mobilizadas do que nós” – Sala de discussão em português 2, Diálogo 2

*Algumas citações abrangem conceitos duplos.

Prioridade nos próximos passos/recomendações

Dados os múltiplos fatores que influenciam a interação entre a mudança climática e a saúde mental na América Latina e no Caribe (ALC), os financiadores, pesquisadores e formuladores de políticas devem procurar urgentemente adotar um método multissetorial que, fundamentalmente, percebe a administração dos recursos da terra como inseparáveis do desenvolvimento e do bem-estar humano contínuo.

As instituições de financiamento devem:

- Criar um compartilhamento de recursos através de instituições de diversos setores para ampliar o financiamento/recursos disponíveis (por exemplo, reunir recursos de financiadores tradicionais da saúde e da pesquisa de resposta de segurança).
- Criar reservas dedicadas ao clima e à saúde mental dentro do fluxo de recursos existente explicitamente de longo prazo (por exemplo, pesquisa de política alimentar).

As instituições de financiamento e pesquisa devem priorizar projetos que:

- Criam ou ampliam sistemas de segurança climática e de saúde mental; isso ajudará no entendimento das interações epidemiológicas de base entre o clima e a saúde mental na região.
- Criam e validam ferramentas de diagnóstico do clima e da saúde mental (por exemplo, aquelas necessárias para a eco-ansiedade).
- Incluem componentes práticos para expandir a saúde mental e/ou o bem-estar mental no contexto de mudança climática ao nível comunitário (preferencialmente com sustentabilidade demonstrável e alto impacto na comunidade).

Traduzir uma base crescente de evidências em ações que possam responder aos impactos da mudança climática sobre a saúde mental

A base de evidências atual sobre as conexões entre a mudança climática e a saúde mental obriga a ação em políticas e na prática, para prevenir necessidades de saúde mental crescentes e promover ações climáticas co-benéficas. Como as evidências atuais e os novos insights criados através da implementação desta agenda podem melhor se traduzir em mudanças nas decisões e práticas políticas em espaços regionais de clima e saúde mental?

Esta seção apresenta uma síntese das discussões de diálogo e resultados da pesquisa, descrevendo os desafios e oportunidades para traduzir evidências geradas através da pesquisa em políticas e práticas.

Tabela 5: Traduzir a base crescente de evidências em ações que possam responder aos impactos da mudança climática sobre a saúde mental*

Conceito	Resumo	Apoio às citações dos participantes**
Estado desejado	Os conjuntos de evidências seriam usadas para influenciar ou apoiar os responsáveis pelas decisões nas múltiplas esferas políticas que afetam o nexa entre o clima e a saúde mental. Isso exigirá educação, engajamento, comunicação e envolvimento com os formuladores de políticas e vários agentes em toda a sociedade (por exemplo, mídia para atrair adesão; financiamento e apoio geral para aumentar a sensibilização da comunidade).	<i>"Ativismo com as autoridades que propõem medidas de CC para comunidades vulneráveis no Caribe e Hati em particular (Unidade de Saúde Pública-Saúde Mental e o Ministério do Meio Ambiente). Estas questões não estão atualmente na agenda... são apresentados os resultados da pesquisa, bem como os efeitos sobre as comunidades afetadas por desastres associados às mudanças climáticas, incluindo o impacto sobre o deslocamento (migrações internas)." – Sala de discussão em francês, Diálogo 2</i>
Desafios	• A relativa novidade da saúde mental e mudança climática como sendo assuntos de significância pública; portanto, o assunto pode estar baixo na	<i>"E em relação às mudanças climáticas, é difícil fazer essa conexão. Por que as mudanças climáticas afetaram minha qualidade de vida ou minha saúde mental? Na qualidade de vida, às vezes é</i>

	lista de prioridades de agendas de ações políticas e sociais. • Estigma social envolvendo a saúde mental, que apresenta dificuldades para o aumento da sensibilização e definição de prioridades a nível político	<i>fácil fazer uma associação. Na comida, é fácil fazer uma associação agora. Na saúde mental, é difícil porque é como se fosse uma coisa velada.....Primeiro, a saúde mental é uma coisa velada, eu acho, em nossa população. Pelo menos, na população brasileira. Eu vejo isso como algo assim. Abordar o tema da saúde mental é algo muito sério. Você não pode continuar dizendo isso em qualquer lugar, a qualquer hora. E até associá-lo à questão das mudanças climáticas é ainda mais complexo... As pessoas estão sempre dizendo: "Precisamos falar sobre isso". Até recentemente, nem sequer podíamos falar de suicídio, por exemplo. Não conseguimos nem falar de depressão."</i> – Sala de discussão simultânea em português, Diálogo 2
Oportunidades e facilitadores	• Obter o atual interesse no campo • Salientar situações de aguda crise climática para salientar a urgência de uma resposta e a necessidade de soluções de longo prazo • Potencializar as preparações comunitárias e ação coletiva	<i>"O tempo é um catalisador e um estresse, por exemplo: o aumento do nível do mar, as pessoas estão cientes de que a perda de território está chegando. O impacto sobre as estações e as chuvas, as colheitas, os mangues que protegem as cidades costeiras também são impactados; essas mudanças podem ser catalisadores para que os responsáveis pelas decisões tomem medidas".</i> – Sala de discussão em francês, Diálogo 2
Potenciais parceiros de relevância	• Partes interessadas governamentais/de Estado, incluindo ministérios de desenvolvimento e serviços de saúde • Partes interessadas não-governamentais, incluindo representantes de escolas, universidades, comunidades litorâneas e da montanha, pessoas com deficiência, organizações de saúde mental, igrejas, comunidades de plantio e de pesca, mulheres e associações de sobreviventes de violência e organizações de base • Empresas do setor privado com o potencial, ou potencial	<i>"Todos os níveis de governo, desde o gabinete do prefeito até o presidente....Estes seriam elementos facilitadores... facilitadores na criação de políticas públicas ou na implementação ou criação e implementação de políticas públicas?"</i> – Sala de discussão em português, Diálogo 1 <i>"...você quer trazer as partes interessadas que serão influentes na elaboração de políticas. Então, não é como se você fizesse sua pesquisa, você tivesse suas conclusões, você tivesse um resumo de políticas, e agora você iria para as pessoas com o poder. Você quer que eles participem desde o início, para que possam aderir ao seu projeto, e se tornem parte da solução desde o primeiro dia".</i> –

percebido, de impactar negativamente os ecossistemas da região (por exemplo: produtores de fertilizantes, agronegócio e grandes consumidores de terra e água)

- **Entidades internacionais**, tais como agências da ONU, organizações das mulheres, associações médicas, associações psicológicas e centros de pesquisa

Sala de discussão em inglês 2, Diálogo 2

"Você pode criar essas políticas, mas ainda precisa do apoio da comunidade para realmente fazê-las a entrar em ação" – Sala de discussão em inglês 2, Diálogo 2

"Para nos ramificarmos nas mídias sociais, e quem podem ser nossos parceiros, acho que isso vai muito bem com os influenciadores, para realmente chamar a atenção dos jovens, porque eles desempenham um cargo muito importante no desenvolvimento de nosso futuro e nosso presente". – Sala de discussão em inglês, diálogo 2

**Por favor, note que existem sobreposições nas conclusões, o que reflete a abordagem sinérgica provável que será necessária para concretizar a agenda de pesquisa.*

***Algumas citações abrangem conceitos duplos.*

Prioridade nos próximos passos/recomendações para investidores e atores

Os formuladores de políticas devem:

- Criar mecanismos para aprimorar a educação e o treinamento médico no campo do clima e saúde mental.
- Incorporar o clima e a saúde mental às políticas/componentes prioritários do sistema de saúde (por exemplo, clima e saúde mental como parte da cobertura universal de saúde, cuidados primários de saúde e respostas a pandemias).

Os financiadores, formuladores de políticas e pesquisadores devem:

- Refletir e projetar formas culturalmente apropriadas de traduzir evidências através de vários ambientes geográficos, grupos populacionais e idiomas.
- Envolver-se com a mídia e outros atores para apoiar a tradução das evidências.
- Investir em campanhas organizadas de defesa do clima e da saúde mental na região para reduzir o estigma.

Discussão: pontos fortes, limitações e próximos passos para a agenda de pesquisa e ação

O projeto CCM foi um exercício novo e uma oportunidade tremenda de reunir conhecimentos vividos em uma grande região multicultural, multilíngue, com países em todos os níveis de desenvolvimento

humano. Os pontos fortes e as limitações do projeto são brevemente descritos abaixo, com vistas aos próximos passos possíveis.

Pontos fortes

- Trazer à tona necessidades e experiências não ouvidas ou registradas anteriormente na literatura.
- Diversidade de peritos reunidos e compartilhados dentro e entre regiões.
- Possibilidade de intercâmbio acadêmico e de experiências vividas em diversas línguas, que pode ter sido limitado por barreiras linguísticas que tradicionalmente criaram separações na região.
- Engajamento significativo da especialização em experiências vividas que orienta esse trabalho.
- Aumento de sensibilização sobre o nexo de clima e saúde mental na ALC.
- Valor pessoal de estar envolvido para os participantes (incluindo espaços seguros para compartilhar o que eles e suas comunidades enfrentam, bem como desenvolver suas habilidades, capacidades e conexões).
- Criação de uma nova metodologia para pesquisa de experiência vivida transcultural e gerenciamento de grandes conjuntos de dados qualitativos na ALC.

Limitações

- Equilibrar a urgência de desenvolver uma agenda de pesquisa e ação para este campo em rápido crescimento com encontros significativos, desenvolvimento de relacionamentos e movimentos a um ritmo que inspire confiança, especialmente com grupos frequentemente sujeitos a processos de pesquisa extractiva (ou seja, povos e nações indígenas).
- Abordar a magnitude e a integridade dos desafios que este trabalho procura começar a superar (setores desconectados, desiguais, isolados e processos de pesquisa).
- Desafios de encontro virtual (por exemplo, tecnologia sendo uma barreira para alguns participantes).
- Construir processos (por exemplo, compartilhamento de dados e ética) do zero (também é um ponto forte).
- Os desafios de equilibrar a necessidade da padronização com a contextualização local e a necessidade de garantir o uso de terminologias locais e compreensões culturais (isto também poderia ser um ponto forte em relação à forma como desenvolvemos métodos globalmente com grupos de trabalho tendo oportunidades de representação em todas as regiões).
- Estigma/tabu da saúde mental e questões de identidade de gênero na região. É possível que os elementos de design de pesquisa que associam ao nome, sexo e estado de saúde mental (embora sejam confidenciais) possam ter influenciado as taxas de resposta.

Conclusão

Participantes da ALC percebem e vivenciam múltiplas e variadas ameaças à saúde mental e ao bem-estar mental em decorrência dos eventos climáticos agudos e progressivos. Dada a crescente intensidade dessas ameaças, precisamos estabelecer, de forma colaborativa, os princípios fundamentais para a elaboração de intervenções baseadas no clima e na saúde mental, com o apoio de uma plataforma para a disseminação e implementação dessas intervenções. Para o alcance dessas metas é necessário uma abordagem de pensamento sistêmico, operando através de todos os setores e disciplinas, devendo incluir uma ampla gama de partes interessadas desde os estágios de formação. Essa tarefa necessitará de apoio

significativo de atores e financiadores regionais e internacionais, mas pode ser alcançada por meio de ações unificadas e formas respeitosas e inclusivas de trabalho.

Audiência da comunidade regional de prática

No final do processo de diálogo, pedimos aos participantes que apresentassem reflexões sobre o que esperavam que surgisse da RCoP. Em homenagem aos seus pensamentos, apresentamos aqui uma lista de todos os comentários, como uma parede virtual de memória das esperanças desses pioneiros em relação à saúde mental e ao clima na ALC.

- Yo haré procesos de incidencia en la organización donde trabajo para que se aborden tema de saúde mental y cambio climático para el beneficio de las comunidades indígenas (Vou realizar processos de defesa na organização onde trabalho para que questões de saúde mental e mudanças climáticas sejam abordadas em benefício das comunidades indígenas).
- Vou compartilhar um resumo de políticas sobre mudanças climáticas e saúde mental em crianças.
- Vou contribuir defendendo globalmente políticas que capacitem os jovens para serem educados, treinados e empregados para resolver os problemas.
- Yo contribuiré a divulgar lo aprendido y discutido. (Vou contribuir para a divulgação do que foi aprendido e discutido.)
- Manterei as ligações que fiz hoje para tomar medidas sobre questões relacionadas à saúde mental e aos efeitos das mudanças climáticas.
- Continuarei a destacar as vozes dos jovens na agenda do clima e da saúde mental. Além disso, comprometo-me a começar a aumentar a sensibilização sobre a conexão deste assunto na minha cidade e nos espaços que estou matriculado.
- Estarei pensando em como a minha contribuição pode ser mais eficaz, trabalhando com diferentes atores para implementar melhores soluções.
- Vou ter impacto na minha comunidade.
- Procurarei integrar as questões relacionadas à saúde mental e a CC integrada na Ferramenta de Informação sobre Riscos da Comunidade do Caribe (CCRIT) e outros mundos de resiliência comunitária relacionados.
- Garantirei que os contextos com menor capacidade sejam considerados.
- Vou acompanhar as consequências deste projeto e ajudar com tudo o que puder ao longo do caminho.
- Yo hare mis próximas investigaciones con enfoque de salud mental. (Eu farei minha próxima pesquisa com foco em saúde mental).
- Continuarei a considerar a saúde mental como um elemento chave para a sanidade.
- De esta comunidad me gustaria ver acciones concretas en el campo de salud mental y cambio climático. (Dessa comunidade gostaria de ver ações concretas no campo da saúde mental e das mudanças climáticas).
- Desta comunidade, gostaria de ver caminhos práticos para a pesquisa relevante e a elaboração de políticas.
- Desta comunidade eu gostaria de ver parcerias duradouras.
- Desta comunidade eu gostaria de ver uma mudança real de política em toda a região.
- Gostaria de ver o painel/plataforma ser mantido após este ciclo de pesquisa terminar.
- Mais evidências científicas geradas e mais políticas implementadas.

- De esta comunidad quiero contar con apoyo técnico, político y si fuera posible económico para algunas acciones. (Desta comunidade quero ter apoio técnico, político e, se possível, económico para algumas ações).
- Gostaria de ver uma sistematização clara das principais conclusões e como podemos iniciar ações.
- Nesta comunidade eu gostaria de ter mais trabalho de divulgação envolvendo saúde mental e mudanças climáticas.
- Nesta comunidade eu gostaria de ver oportunidades para pesquisa colaborativa.
- Gostaria de ver esforços estratégicos para integrar as questões de saúde mental nas políticas de desenvolvimento e sociais existentes.
- Nesta comunidade eu gostaria de ver a criação de vias de mudança disponíveis para os jovens, preenchendo as lacunas nas organizações que já existem e expondo a saúde mental às pessoas nas áreas rurais.
- Nesta comunidade eu gostaria de ver nossa própria comunidade crescendo em sensibilização e esperança.

Glossário de termos

Para obter um glossário que descreve conceitos relevantes e palavras-chave para as agendas de pesquisa e ação do Connecting Climate Minds, faça o download [aqui](#).

Quem produziu este relatório

Declaração de contribuição do autor

Dra. Natalie Greaves, Professora de Saúde Pública, Coordenadora MPhil/PhD em Saúde Pública e Epidemiologia, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade das Índias Ocidentais (UWI) Cave Hill

Dra. Satish Jankie, Professor de Farmacologia, Escola de Farmácia, Faculdade de Ciências Médicas, UWI St. Augustine

Dra. Shamjeet Singh, Professor de Ciências Básicas Integradas da Saúde, Escola de Farmácia, Faculdade de Ciências Médicas, UWI St. Augustine

Embaixadora Gillian M. S. Bristol, Diretor do Centro Latino-Americano e do Caribe (LACC), UWI Mona

Dra. Elizabeth Mandeville, Consultora Independente

Dr. Michael Campbell, Professor Sênior de Ciências Comportamentais/Psicologia e Vice-Reitor (Pesquisa e Pós-Graduação), UWI Cave Hill

Nienke Meinsma, Pesquisadora Júnior de Políticas sobre Mudanças Climáticas e Saúde, Climate Cares Centre, Instituto de Inovação em Saúde Global, Imperial College London

Jessica Newberry Le Vay, Bolsista de Mudança Climática e Política de Saúde, Climate Cares Centre, Instituto de Inovação em Saúde Global, Imperial College London

Didi Thompson, Pesquisadora Honorária, Centro de Políticas de Saúde, Instituto de Inovação em Saúde Global, Imperial College London

Dra. Emma J Lawrance, Centro Climate Cares, Instituto de Inovação em Saúde Global, Imperial College London

Dra. Sandeep Maharaj, Diretor, Escola de Farmácia, Faculdade de Ciências Médicas, UWI St. Augustine

Este é um trabalho independente, de autores com o apoio e a contribuição da equipe do Connecting Climate Minds.

Agradecimentos

A equipe do Connecting Climate Minds e da América Latina e do Caribe agradece a todos que contribuíram para a produção dessa pesquisa. A variedade geográfica dentro das regiões tornou-se um desafio para alguns participantes, por isso expressamos nosso sincero agradecimento àqueles que contribuíram com seu tempo e conhecimento.

Adrian Trotman

Alejandro Herrera-Aguayo

Ana Gabriela Mejia

Ana Sfoggia

Antonia Faustina Xuruc Barreno

António Saraiva

Athena Adoración Flores Torres

Bidyadhar Sa

Carlos Arroyo

Carolina Somarribas Dormond

Cesar Castillo

Chris Oura

Claudia Buchweitz

Cleefedwens Fortuné

Danelia Pineda

Darren K. Dookeeram

Doris Keens-Douglas

Edward Mark

Olga Falceto

Felipe Nora

Frandy Jules

Gabriela Aurora Martínez Ramírez

Garvey Myrvelt Louis Jean

Georgiana Gordon-Strachan

German Casco

Gloria Blaise

Grace Kelly Bent

Hariharan Seetharaman

Harvey Vijay Sharma

Heather Armstrong

Jacqueline Laguardia Martinez

Jean Mary Alexandre

Jeremy Collymore

Jonathan Sherin

Katherin Vivianne Fuentes Rodríguez

Kenzy Jean Pierre

Lisa Benjamin

Marcela De la Garma

Marcia Mandepora Chundary

Mayara Floss

Michael H. Campbell

Nelzair Araujo Vianna

Norton Gilberto Chavarria Francis

Raquel Tupinambá

Renato Oliveira e Souza

Rolando Sierra

Rosa Elizabeth Flores Gómez

Salvador López

Sandra Reid

Satish Jankie

Serafina Espinoza Blanco

Shamjeet Singh

Shane Kirton

Silvel Elías

Vashti-Eve Burrows

Vilma Crovetto

Vinson Bradley Noel

Xóchitl Garza Olivares

Além disso, o trabalho não poderia ter sido realizado sem o conhecimento, diligência, interesse e suporte dos co-organizadores, das Pessoas com Experiência de Vida e dos Jovens Embaixadores.

Pessoas com cargos de liderança inaugural:

Embaixador Gillian Bristol e Dr. Sandeep Maharaj.

Co-organizadores e facilitadores: Dra. Enrique Falceto de Barros, Docente Investigador Msc Marcos Leonardo Williamson Cuthbert, Dra. Marta Rosa Munoz, Dra. Fresia Hernandez, Dra. Dassaëve Brice, Dra. Clemencia Ramirez, Dra. Tatiana Camargo, Dra. Raquel Santiago e o Professor Jonathan Sherin.

Grupo de experiências vividas: Srta. Vashti-Eve Burrows, Srta. Gloria Blaise, Srta. Raquel Tupinamba, e Sr. Norton Chavarria.

Jovens Embaixadores: Srta. Ana Gabriela Mejia e Sr. Harvey Vijay Sharma.

Analistas da pesquisa: Dra. Satish Jankie e Dr. Shamjeet Singh.

O time estende os agradecimentos à Dra. Natalie Greaves por sua expertise técnica e a liderança na análise qualitativa dos dados apresentados durante este relatório.

Financiamento

Este projeto foi financiado pela Wellcome.

Conflitos de interesse

Os autores não têm nenhum conflito de interesse a declarar.

Traduções

Agradecemos aos Climate Cardinals pelas traduções.



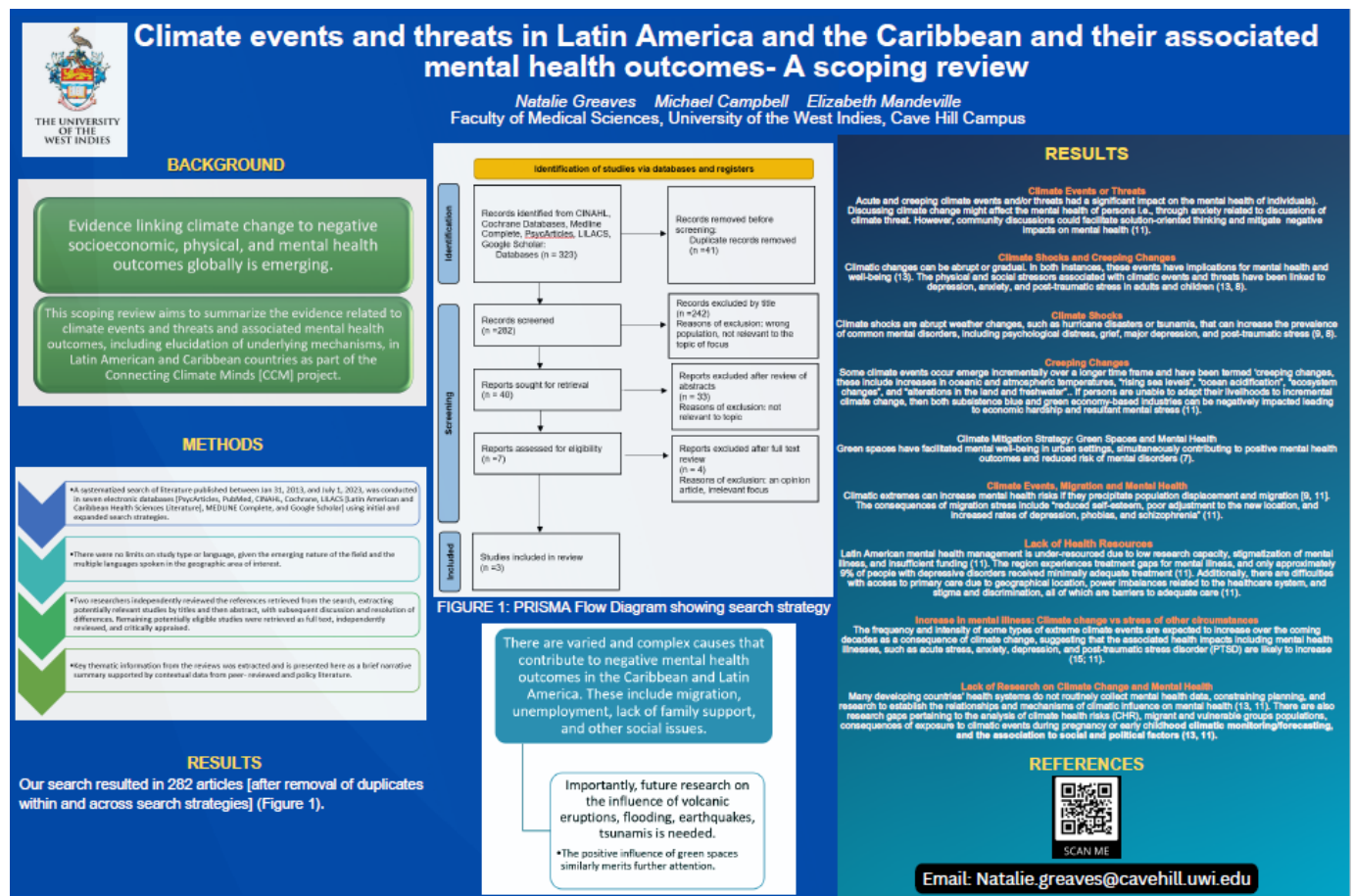
Apêndice

Apêndice 1: Pontos recomendados para intervenção política com base na revisão de escopo da literatura

1. Melhorar a organização e a prestação dos serviços de saúde mental, incluindo os que atendem às necessidades da infraestrutura de saúde mental das populações indígenas em geral.⁸
2. Desenvolver e implementar programas de capacitação entre os membros da comunidade para fornecer Primeiros Socorros Psicológicos.
3. Desenvolver e fornecer formação para profissionais de saúde sobre as associações entre saúde mental e eventos climáticos.²⁴
4. Estabelecer continuidade dos mecanismos de cuidados para pessoas com saúde mental durante eventos meteorológicos adversos.²⁴
5. Desenvolver e implementar programas para facilitar o bem-estar mental através de adaptações antecipadas às mudanças climáticas.²⁴
6. Implementar mecanismos de vigilância passiva para a saúde mental, incluindo a Classificação Internacional de Doenças (ICD-10 ou 11).¹⁰
7. Desenvolver programas comunitários de promoção da saúde sobre a interação entre saúde mental e mudanças climáticas.⁵
8. Discutir as mudanças climáticas para abrir conversas sobre os impactos prejudiciais para a saúde mental.⁹
9. Utilizar um processo participativo para a elaboração de políticas públicas sobre mudanças climáticas e resiliência, reconhecendo que as pessoas têm o direito de se envolver no planejamento local-global, na tomada de decisões e na ação.⁵

Apêndice 2: Poster resumindo elementos dos resultados da revisão de escopo narrativa

- Resumo da metodologia - A revisão examinou literatura publicada entre 31 de janeiro de 2013 e 1º de julho de 2023, e foi realizada em sete [7] bancos de dados eletrônicos (PsycArticles, PubMed, CINAHL, Cochrane, LILACS [Literatura de Ciências da Saúde da América Latina e do Caribe], MEDLINE Complete e Google Scholar¹) usando estratégias de pesquisa inicial e expandida. Não havia limites para o tipo de estudo ou idioma, dada a natureza emergente do campo e as várias línguas faladas na área geográfica de interesse.



Climate Events or Threats
Acute and creeping climate events and/or threats had a significant impact on the mental health of individuals). Discussing climate change might affect the mental health of persons i.e., through anxiety related to discussions of climate threat. However, community discussions could facilitate solution-oriented thinking and mitigate negative impacts on mental health (11).

Climate Shocks and Creeping Changes
Climatic changes can be abrupt or gradual. In both instances, these events have implications for mental health and well-being (13). The physical and social stressors associated with climatic events and threats have been linked to depression, anxiety, and post-traumatic stress in adults and children (13, 8).

Climate Shocks
Climate shocks are abrupt weather changes, such as hurricane disasters or tsunamis, that can increase the prevalence of common mental disorders, including psychological distress, grief, major depression, and post-traumatic stress (9, 8).

Creeping Changes
Some climate events occur emerge incrementally over a longer time frame and have been termed 'creeping changes, these include increases in oceanic and atmospheric temperatures, "rising sea levels", "ocean acidification", "ecosystem changes", and "alterations in the land and freshwater".. If persons are unable to adapt their livelihoods to incremental climate change, then both subsistence blue and green economy-based industries can be negatively impacted leading to economic hardship and resultant mental stress (11).

Climate Mitigation Strategy: Green Spaces and Mental Health
Green spaces have facilitated mental well-being in urban settings, simultaneously contributing to positive mental health outcomes and reduced risk of mental disorders (7).

Climate Events, Migration and Mental Health
Climatic extremes can increase mental health risks if they precipitate population displacement and migration [9, 11]. The consequences of migration stress include "reduced self-esteem, poor adjustment to the new location, and increased rates of depression, phobias, and schizophrenia" (11).

Lack of Health Resources
Latin American mental health management is under-resourced due to low research capacity, stigmatization of mental illness, and insufficient funding (11). The region experiences treatment gaps for mental illness, and only approximately 9% of people with depressive disorders received minimally adequate treatment (11). Additionally, there are difficulties with access to primary care due to geographical location, power imbalances related to the healthcare system, and stigma and discrimination, all of which are barriers to adequate care (11).

Increase in mental illness: Climate change vs stress of other circumstances
The frequency and intensity of some types of extreme climate events are expected to increase over the coming decades as a consequence of climate change, suggesting that the associated health impacts including mental health illnesses, such as acute stress, anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder (PTSD) are likely to increase (15, 11).

Lack of Research on Climate Change and Mental Health
Many developing countries' health systems do not routinely collect mental health data, constraining planning, and research to establish the relationships and mechanisms of climatic influence on mental health (13, 11). There are also research gaps pertaining to the analysis of climate health risks (CHR), migrant and vulnerable groups populations, consequences of exposure to climatic events during pregnancy or early childhood climatic monitoring/forecasting, and the association to social and political factors (13, 11).

Apêndice 3: Agendas do diálogo

Diálogo 1

Hora (min)	O quê	Como
0-20	Bem-vindo e introduções	
20-35	Exercício de visão	Exercício de visão: "Manchetes" na plataforma Climate Centre Good Games Os participantes compartilham o que esperam obter ao fazer parte do Connecting Climate Minds e por que estão interessados nesse tópico

		<i>Imagine que estamos em 2030 e o projeto CCM recebeu um importante prêmio por suas realizações em reunir CC/MH em sua região e fazer a mudança para o clima e saúde mental juntos através da pesquisa e ação. Você é entrevistado por um jornalista enquanto você está celebrando ter ganhado o prêmio</i> Criar/votar e revisar Manchetes criadas na Good Games Platform
35-50	Ambiente da cena	Breve contexto das associações entre as mudanças climáticas e a saúde mental O que estamos ouvindo na região que podemos nos reunir e responder: compartilhando destaques de pre-escopo Apresentação e perguntas e respostas da Connecting Climate Minds
50-95	Sessão de discussão 1: Necessidades regionais	Anfitrião prepara a cena para as salas de discussões Compartilha a visão geral dos perigos climáticos para a região Grupos de discussão Facilitador lidera o grupo em uma discussão sobre as adversidades à saúde mental decorrentes das mudanças climáticas na região. As perguntas feitas aos participantes foram: • <i>Do seu ponto de vista, quais são os perigos climáticos que mais lhe preocupam em termos de saúde mental e bem-estar?</i> • <i>Para cada perigo, discuta o seguinte:</i> ○ <i>Quem está sendo impactado? Há grupos mais expostos ao risco?</i> ○ <i>Quais são os resultados de saúde mental e bem-estar associados a este perigo?</i> ○ <i>Como esse perigo afeta especificamente a saúde mental e o bem-estar; quais são os mecanismos, por exemplo, habitação, meios de subsistência, etc.</i> ○ <i>Encorajar as pessoas a analisar diferentes tipos de mecanismos, por exemplo, sociais, biológicos, culturais, ambientais</i> ○ <i>Ações de adaptação/mitigação climática – o que está a sendo feito, o que pode ser feito?</i> ○ <i>Ações que estão sendo/poderiam ser tomadas para melhorar ou promover a saúde mental e o bem-estar neste contexto</i> Breves destaques da sessão plenária
95-105	Pausa	
105-110	Prévia do que está acontecendo	O desenhista de desenho animado compartilha um primeiro rascunho que reflete parte do conteúdo da sessão até o momento.

		O anfitrião convida os participantes a compartilhar no chat, como a imagem ressoa.
110-160	Sessão de discussão 2: Lacunas e evidências de pesquisa	Grupos de discussão [mesmo participantes, facilitador e tomador de notas como na primeira sessão de discussão] Olhando para trás para a tabela de perigos da sessão de discussão 1 como ponto de partida, os participantes são guiados para começar a pensar sobre onde mais pesquisas são necessárias. Os anfitriões convidam 2 ou 3 facilitadores para compartilhar algumas breves reflexões
160-170	Reflexão de desenho animado sobre a produção de diálogo	Os participantes revisam individualmente cada desenho animado e compartilham suas reflexões. Isso pode variar de: sugestões de mudanças para torná-lo mais preciso, para compartilhar como ele se relaciona com a nossa realidade, ou quaisquer outros insights.
170-180	Conclusão e próximos passos	O anfitrião compartilha um resumo de alto nível da sessão, agradece a todos e celebra esta primeira reunião da comunidade regional. Os participantes completam um breve pesquisa para fornecer feedback sobre o diálogo

Diálogo 2

Tempo (min)	O quê	Como
0-5	Exercício de mapa mundial	O anfitrião pede aos participantes para colocar um ícone de “estrela” onde eles estão atualmente e, em seguida, pegar o ícone de “coração” e colocá-lo onde eles gostariam de visitar um dia ou um lugar que eles estiveram e realmente gostaram/sentiram especialmente conectado.
5-15	Bem-vindo e introduções	
15-30	Compartilhando atualizações	Apresentação sobre os progressos global e regional e os resultados do diálogo 1, incluindo visão, temas de pesquisa prioritários.

30-50	Feedback dos temas de pesquisa prioritário	Jamboard compartilhado na tela. O anfitrião apresenta a atividade dos temas de pesquisa prioritária e pede às pessoas que considerem as seguintes perguntas: Perguntas de pesquisa • É um tema valioso? Você adicionaria ou mudaria alguma coisa? • Compartilhe quaisquer ideias sobre conjuntos de dados, métricas ou métodos que possam ser aplicados para ajudar a resolver isso. Temas de pesquisa • O que seria mais útil saber sobre este tópico para entender e responder a ele? • O que você gostaria de saber primeiro? A música toca e os participantes trabalham independentemente no Jamboard a seu próprio ritmo.
50-55	Ambiente da cena para discussões	O anfitrião define a cena para as salas de discussões. Interessado no “como”, que inclui os princípios e resultados desejados para pesquisa, política e prática na região. A discussão permitirá direcionar ações e investimentos para, tanto implementar a agenda de pesquisa na região, como para garantir que a evidência sobre onexo, clima e saúde mental, seja traduzida em políticas e práticas
55- 90	Discussão 1	Oito grupos de saída. Os quatro primeiros sobre o tema “Criar conhecimento através da pesquisa” (por exemplo, como podemos melhor implementar a agenda de pesquisa?) e os outros quatro sobre “Cultivar políticas e ações baseadas em evidências” (por exemplo: Como podemos traduzir a crescente base de evidências em ações em política e prática?). Cada grupo usa um Jamboard para discutir: 1) Como isso se parece quando é bem feito? 2) Quais oportunidades e facilitadores existem? 3) Que desafios devemos superar? 4) Quem devem ser os nossos parceiros e partes interessadas? Breves destaques da sessão plenária
90-100	Pausa	
100-105	Desenhe seus sentimentos	O anfitrião recebe todos de volta e convida todos que gostariam de se juntar a pegar um pedaço de papel e uma caneta/marcador (ou digital) e desenhar como eles estão se sentindo hoje. Quem quiser é convidado a mostrar sua imagem para compartilhar algumas reflexões.

105-125	Mapeament o de espectro	O anfitrião apresenta e explica a atividade. Compartilhar tela de Jamboard. Projetado para revelar a diversidade de perspectivas e opções em torno de diferentes conceitos e organizá-los em um espectro significativo. Esta atividade visa iluminar a gama de perspectivas do grupo e organizar essas perspectivas em um continuum. Pergunta: <i>O que esses conceitos significam para você?</i> Concentrando-se em uma placa por vez, o anfitrião pede a todos para silenciosamente gerar um ponto de vista em torno desse conceito e escrevê-lo em uma nota adesiva no Jamboard. As pessoas podem adicionar mais de uma. Uma vez que as notas adesivas são postadas, o anfitrião trabalha com o grupo para classificá-las em uma gama horizontal de ideias. Notas adesivas que expressam perspectivas ou opções semelhantes devem ir lado a lado. Notas adesivas que parecem ser discrepantes, devem ficar sozinhas; elas podem, às vezes, acabar definindo os limites do intervalo. Repita com os restantes conceitos. No final, peça observações e insights sobre a configuração do terreno. E se alguma perspectiva ou opção foi excluída. Se sim, adicione-a e re-ordene conforme necessário.
125 - 155	Discussão 2	O anfitrião apresenta a segunda rodada de salas de discussão e fornece um resumo de 2 minutos das contribuições de Jamboard da primeira discussão. Os 8 grupos originais se reúnem e elaboram e acrescentam novas ideias aos seus pensamentos iniciais. É permitido aos grupos continuar sobre o tema que já estavam discutindo ou mudar de tema.
155- 175	Eu vou... Eu quero...	O anfitrião pede a todos para refletir individualmente acerca de como eles podem contribuir com este espaço, além de compartilhar uma declaração do tipo “Eu vou” no bate-papo, mas apenas aperte Enter conforme solicitado. Após um minuto, o anfitrião convida todos a apertar Enter ao mesmo tempo para revelar as declarações. Isto é repetido com uma declaração do tipo “Desta comunidade, eu gostaria de ver...”.
175	Conclusão e próximos passos	O anfitrião compartilha um resumo de alto nível da sessão, agradece a todos e descreve os próximos passos. Os participantes completam um breve pesquisa para fornecer feedback sobre o diálogo

Apêndice 4: Metodologia de análise para os Diálogos 1 e 2



Analytic Data reduction steps-Dialogue 1

- Four analysts (NG, SM, SJ, and SS) from varied health sciences backgrounds and who were involved in either the design and or execution of the dialogue coded the data and formulated the thematic concepts.
- The analysts first established consistency in interpretation of codes and coding method by independently coding 4 pages of dialogue with subsequent discussion and resolution of differences. Once this quasi- interrater reliability was established the transcript data set was divided amongst the analysts. Each transcript was then coded by one analyst with subsequent quality check for consistency in application of the coding frame by a second analyst.
- A group discussion was held after the coding of 4 FG transcripts to discuss emerging themes and the steps to be taken in condensing the data using a framework/ matrix analysis method (in this instance the goal was to progress from basic to organizing themes, to an overarching global theme).



Analytic Data reduction steps-Dialogue 2- Jamboards

Google Jamboard sheets from the refinement of research question activity were divided among the analysts (NG, GB, SM, SS and SJ). The analysts then compared all responses to a given question with original thematic summaries from dialogue 1, with the aim of identifying any critiques, changes (including expansions) to the questions/ thematic scope of the questions as articulated). The changes as articulated by participants were then summarized as eight priority research themes reflected in 26 questions to inform the research agenda in the LAC. (These questions were shared worth participants in the post dialogue survey).

Apêndice 5: Critérios de seleção dos temas de pesquisa prioritários

Os critérios de seleção dos temas de pesquisa prioritários foram gerados com base em debates com especialistas de todo o mundo por diversos setores e disciplinas, e com base em critérios de seleção utilizados em outros exercícios de definição de prioridades de pesquisa.²⁵ Os critérios foram aplicados por meio de consultoria da equipe de análise.

- O tema da pesquisa responde a uma lacuna de evidências existente?
- O tema da pesquisa tem potencial para informar a tomada de decisão na política e na prática?
- Ele reflete um ou mais dos seguintes elementos:
 - o identificou os maiores adversidades à saúde mental associados às mudanças climáticas na região

- identificou os maiores riscos climáticos na região
- os formuladores de políticas que mais precisam para atender às necessidades emergentes/superar obstáculos à ação
- alinhamento com o que os especialistas por experiência própria expressaram como sendo desafios na região
- Seria viável realizar esta pesquisa?
- É elaborada para ser compreensível, específica e prática para a comunidade científica abordar de maneira significativa? Um pesquisador ou um financiador com experiência relevante conseguiria entender este tema?
- É específico o suficiente para ser significativo e guiar pesquisa focada (caso muito ampla ou vaga, não vai ajudar a canalizar os recursos de maneira significativa)
- Ela ajuda os financiadores a investir nesta área (considere o que é relevante para a região)?

Apêndice 6: Estruturas de codificação da agenda de pesquisa e da agenda de ação

Categoria de pesquisa	Subcategorias
1. Impactos, Riscos e Grupos Vulneráveis Esta categoria trata de melhorar nossa compreensão sobre as maneiras pelas quais a saúde mental é afetada pelas mudanças climáticas. Por exemplo: quais resultados de saúde mental são afetados ou estão em risco; a prevalência, a gravidade, os custos financeiros e sociais desses impactos; e quem está mais vulnerável a esses impactos. Esta categoria também inclui as maneiras pelas quais podemos melhorar a compreensão dos impactos da mudança climática na saúde mental – os métodos e métricas que precisamos para avaliar e monitorar a saúde mental de maneiras	<i>Considerações transversais que devem ser levadas em conta para todas as subcategorias:</i> <i>Cronograma</i> <i>Variação geográfica</i>
	1.1. Pesquisa que se concentra na prevalência, gravidade e natureza da experiência de diferentes consequências/desafios/experiências de saúde mental afetados por diferentes aspectos da mudança climática. Isso pode incluir pesquisas para entender o surgimento de experiências de saúde mental específicas do clima e sua relação com desafios de saúde mental já definidos.
	1.2. Quantificar a fração do fardo de saúde mental (incluindo a mortalidade) causada pela mudança climática.
	1.3. Compreender os fatores de risco para a saúde mental que são causados ou afetados pela mudança climática, bem como os fatores de proteção.
	1.4. Identificar subgrupos populacionais (por exemplo, demografia, meios de subsistência, estágio de vida, desafios de saúde mental pré-existent) que experimentam aumento da vulnerabilidade aos desafios de saúde mental causados pela mudança climática e, ao mesmo tempo, aqueles que experimentam resiliência a estes efeitos (ou seja, grupos vulneráveis).

relevantes para a mudança climática, apropriadas e comparáveis ao contexto, etc.	1.5. Quantificar o custo (por exemplo, econômico, social) do fardo adicional para a saúde mental causada pela mudança climática e pela insuficiente ação pelo clima. 1.6. Pesquisa de métodos para identificar os meios mais apropriados para avaliar e monitorar os impactos da mudança climática na saúde mental [incluindo a adaptação de escalas pré-existentes, a criação de novas, a determinação de métricas adequadas de saúde mental e indicadores para inclusão em processos globais como o Lancet Countdown]. Isso também pode incluir a necessidade de validação intercultural e desenvolvimento de métricas culturalmente apropriadas.
2. Caminhos e mecanismos Esta categoria trata de melhorar a nossa compreensão de como a saúde mental é afetada pela mudança climática. Estamos interessados em temas de pesquisa que possam ajudar a identificar, categorizar e entender a variedade de maneiras que a mudança climática ou a ação pelo clima podem afetar a saúde mental. Isso pode incluir considerar caminhos e mecanismos que sejam de natureza biológica, psicológica, social ou ambiental, e podem ser diretos ou indiretos. Observe que os mecanismos podem incluir mecanismos para o desenvolvimento, manutenção e/ou resolução de desafios mentais, o que, portanto, também inclui mecanismos relevantes para orientar o desenvolvimento ou entender o funcionamento das intervenções	<u>Considerações transversais que devem ser levadas em conta para todas as subcategorias:</u> <i>Quais fatores estão associados ao aumento da vulnerabilidade ou maior resiliência para os resultados associados à saúde mental?</i> 2.1. Categorizar e compreender os mecanismos sociais pelos quais a mudança climática afeta negativamente a saúde mental [por exemplo, mudanças nos meios de subsistência, perturbação das práticas culturais, insegurança alimentar e de água, migração forçada, fatores políticos] 2.2. Categorizar e compreender os mecanismos ambientais pelos quais a mudança climática afeta negativamente a saúde mental [por exemplo, poluição do ar, exposição reduzida à biodiversidade] 2.3. Categorizar e compreender os mecanismos psicológicos pelos quais a mudança climática afeta negativamente a saúde mental [por exemplo, como a temperatura afeta as alterações cognitivas relevantes para os sintomas de adversidades à saúde mental]. 2.4. Categorizar e compreender os mecanismos biológicos pelos quais a mudança climática afeta negativamente a saúde mental [por exemplo, impactos de medicamentos psicotrópicos na termorregulação, fatores relativos ao neurodesenvolvimento]. 2.5. Compreender os mecanismos pelos quais as ações pelo clima ou as intervenções em saúde mental beneficiam o clima e a saúde mental (ou seja, mecanismo de eco-benefício). 2.6. Pesquisa de métodos para identificar as maneiras mais apropriadas de avaliar e monitorar os caminhos e mecanismos pelos quais a mudança climática afeta negativamente a saúde mental e o bem-estar (por exemplo, mapeamento de sistemas entre disciplinas)

3. Benefícios da ação pelo clima (adaptação e mitigação) para a saúde mental Entender e quantificar quando e como as ações de adaptação e mitigação do clima, em todos os setores, também podem trazer benefícios mútuos para a saúde mental. Isso inclui quantificar os custos e benefícios da ação pelo clima para a saúde mental, entender o que é necessário para apoiar um melhor alinhamento entre a ação pelo clima e a ação pela saúde mental, e identificar onde esta integração já está acontecendo em todas as estratégias e políticas.	3.1. Identificar ações pelo clima que integram ou alinham os benefícios para a saúde mental [ações climáticas co-benéficas, por exemplo, aumento da arborização nas cidades]
	3.2. Quantificar os co-benefícios da ação pelo clima para a saúde mental (incluindo número de pessoas que experimentam o benefício, dimensão do efeito, considerações econômicas).
	3.3. Explorar como os custos e benefícios para a saúde mental da ação pelo clima podem diferir entre subgrupos da população (por exemplo, demografia, meios de subsistência, estágio de vida)
	3.4. Compreender as ferramentas de apoio de estruturas/decisões de gestão que permitem a coordenação das ações em matéria de mudança climática e de saúde mental entre setores
	3.5. Mapeamento e monitoramento da integração da saúde mental nas políticas de adaptação e mitigação entre setores [por exemplo, Planos Nacionais de Adaptação, energia, transporte, alimentos, água, agricultura]
	3.6. Explorar oportunidades para a saúde mental ser integrada em outras esferas prioritárias do clima, ou seja, perda e dano e financiamento climático.
	3.7. Determinar as melhores abordagens para a ação pelo clima (por exemplo, redução de emissões ou adaptação climática) no setor da saúde mental (garantir que as instalações psiquiátricas possam ser mantidas frescas em ondas de calor; projetos de espaços verdes em instalações de saúde mental)
	3.8. Pesquisa de métodos para identificar os meios mais apropriados para avaliar e monitorar os benefícios para a saúde mental da ação pelo clima [por exemplo, abordagens com base no local, métodos para atribuir e quantificar os co-benefícios, métodos para avaliar as implicações para a saúde mental das decisões em outros setores]

4. Intervenções/soluções de saúde mental no contexto da mudança climática Esta categoria trata de identificar as intervenções/soluções de saúde mental mais eficazes para apoiar a saúde mental no contexto da mudança climática. Isso pode se relacionar com o fornecimento de apoio a pessoas que já estão sofrendo impactos negativos na saúde mental e a redução do risco ou da gravidade de futuros impactos negativos na saúde mental. Isso inclui aprender com o conhecimento de diferentes disciplinas, comunidades e culturas, entender como as intervenções existentes em saúde mental são afetadas pela mudança climática, identificar e avaliar intervenções existentes que são relevantes para o contexto da mudança climática e desenvolver novas intervenções. As intervenções são relevantes em todos os níveis (indivíduo, família, comunidade, sistemas), em todos os setores.	<u>Considerações transversais que devem ser levadas em conta para todas as subcategorias:</u> <i>NÍVEL (por exemplo)</i> <i>Indivíduo, Família, Comunidade, Sistemas</i> <i>MECANISMO (por exemplo)</i> <i>Biológico, Psicológico, Social, Ambiental</i> <i>SETOR (por exemplo)</i> <i>Educação, Serviço de Saúde, Saúde Pública</i> <i>As considerações acerca da eficácia incluem impactos em diferentes grupos populacionais, e considerações de implementação podem incluir provedores, custo e tempo.</i> 4.1. Compreender diferentes modos de saber, ser e fazer em diferentes culturas e comunidades que possam construir resiliência individual, comunitária e ecológica 4.2. Entender como as intervenções existentes em saúde mental são afetadas pela mudança climática 4.3. Identificar e avaliar intervenções em saúde mental que já são concebidas ou relevantes para o contexto da mudança climática e/ou integrar considerações sobre a mudança climática 4.4. Alterar, implementar e avaliar as intervenções em saúde mental de outros ambientes para serem apropriadas aos impactos relacionados com o clima? 4.5. Co-criar, implementar e avaliar novas intervenções que atendam às necessidades de saúde mental relacionadas ao clima 4.6. Comparar a eficiência de custo, considerações de implementação e eficácia entre intervenções para um determinado ambiente e grupo de
--	---

	população para determinar “melhores compras”
	4.7. Identificar, desenvolver e avaliar abordagens para aumentar a sensibilização e o desenvolvimento da capacidade para melhorar a qualificação da força de trabalho para reconhecer e responder aos impactos na saúde mental da crise climática (por exemplo, profissionais de saúde mental, agentes de emergência)

Apêndice 7: Coleta e armazenamento de dados

Diálogos

Os diálogos foram realizados de maneira virtual no Zoom. Os diálogos e os grupos de discussão foram gravados e transcritos por fornecedores terceirizados (Way with Words e Absolute Translations) e os comentários do chat do Zoom foram salvos. No Diálogo 1, os documentos do Word foram usados para capturar notas das salas de discussões. No Diálogo 2, o Jamboard foi usado para capturar notas e para os participantes contribuírem diretamente com comentários.

Pesquisas

A distribuição da pesquisa e a coleta de dados foram realizadas usando a plataforma online Qualtrics. Todos os dados foram coletados pelo Imperial College London e dados anônimos foram compartilhados com a UWI para análise.

Armazenamento e compartilhamento de dados

Os dados foram armazenados e gerenciados pelo Imperial College London usando um servidor seguro. O UWI foi um Controlador de Dados Conjunto para os dados fornecidos a esse projeto para a América Latina e Caribe e responsável pelo armazenamento e compartilhamento seguro de dados com o Imperial College London e com as equipes de analistas regionais. Os dados serão armazenados pelo Imperial College London por 10 anos após a conclusão do estudo.

Apêndice 8: Riscos climáticos na América Latina e Caribe^{22,26}

Riscos climáticos observados na América Latina e Caribe e mudanças previstas

Para orientar discussões informadas sobre as consequências atuais e potenciais para a saúde mental da mudança climática atual e futura na região, é vital garantir uma base na ciência do clima. O Centro Climático da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (CRCV) realizou um mapeamento dos riscos climáticos anteriores e projetados em toda a região para embasar os diálogos e a agenda de pesquisa. O seguinte é um resumo dos riscos relacionados ao clima que a América Latina e o Caribe presenciaram nos últimos 30 anos, e seus aumentos projetados devido à mudança climática até cerca de 2030.

É importante salientar que os dados recolhidos para períodos passados e futuros diferem não só em resolução espacial, mas também se baseiam em diferentes princípios subjacentes. Os primeiros são feitos

através de observações ou eventos documentados, como os relatados pelos serviços meteorológicos nacionais, e são agregados em escala nacional. Os últimos são de estudos com base em modelos climáticos e relatórios de avaliação publicados pelo Grupo Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que são em uma escala espacial mais detalhada. Pela mesma razão, as categorias de riscos relacionados com o clima nos períodos passado e futuro podem às vezes não ser idênticas, mas são geralmente comparáveis ou relacionadas. Por exemplo, as inundações que foram relatadas como um risco climático relevante nos últimos 30 anos não são um resultado direto dos modelos climáticos globais (GCMs). Em vez disso, a variável meteorológica subjacente (chuvas) das simulações de GCMs são usadas para resultar em índices que podem ser considerados como um substituto para potenciais inundações em um futuro aquecimento climático.

ALC

A região da América Latina e do Caribe é uma das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas. Esta região tem presenciado fortes secas, incêndios, inundações, deslizamentos de terra, tempestades e temperaturas extremas nos últimos anos, mostrado pelo banco de dados internacional de desastres EM-DAT. Observe que o número limitado de eventos extremos registrados (por exemplo, temperaturas extremas) pode ser devido aos registros ausentes nos dados EM-DAT por várias razões, tais como má ou rede limitada de observações por satélite e superfície sobre a região, ou relatórios de serviços meteorológicos nacionais limitados. Além disso, a agregação espacial dos dados em escala nacional torna difícil mapear a ocorrência dos riscos passados para os assentamentos humanos. Portanto, o número total de pessoas afetadas, conforme relatado no EM-DAT, pode não ser sempre verdadeiramente representativo da frequência de ocorrências do risco climático subjacente. Por exemplo, um país da América Latina e do Caribe pode ter presenciado ondas de calor frequentes, mas se esses eventos não foram registrados ou ocorreram em regiões desabitadas, o número total de ocorrências discutidas abaixo pode ser uma subnotificação.

Secas anteriores

Secas e incêndios florestais ocorreram com mais frequência no Brasil, consequentemente afetando^{vi} o maior número de pessoas. Um total de 15 desses eventos afetou uma média de 7,6 milhões de pessoas entre 1991-2022 (Figura 1, superior). Durante este mesmo período, 1,4 milhão, 1,2 milhão e 1,1 milhão de pessoas, em média, também foram afetadas no Haiti, México e Guatemala, respectivamente, como resultado de 5 a 7 eventos desse tipo nesses países.

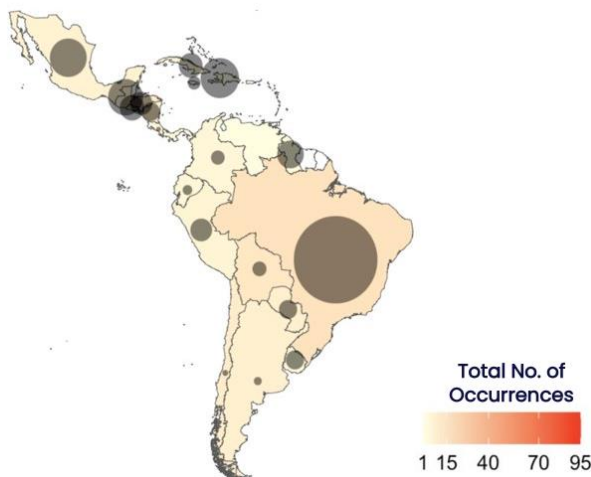
^{vi} A definição EM-DAT de “total de afetados” corresponde a “total de feridos, afetados e desabrigados”.

Drought and Wildfire

Env. Hazards Total Occurrences
& Avg. Affected Population:
1991 – 2022
(Source: EM-DAT)

Average number of
people affected

- < 10K
- 50K
- 100K
- 250K
- 500K
- > 1M

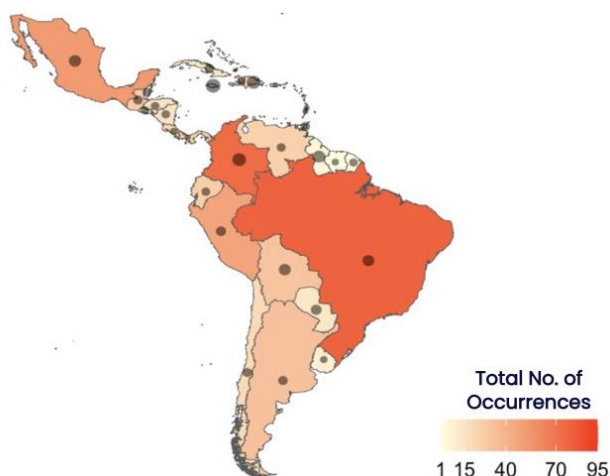


Flood and landslide

Env. Hazards Total Occurrences
& Avg. Affected Population:
1991 – 2022
(Source: EM-DAT)

Average number of
people affected

- < 10K
- 50K
- 100K
- 250K
- 500K
- > 1M



Storm and Extreme Temperature

Env. Hazards Total Occurrences
& Avg. Affected Population:
1991 – 2022
(Source: EM-DAT)

Average number of
people affected

- < 10K
- 50K
- 100K
- 250K
- 500K
- > 1M

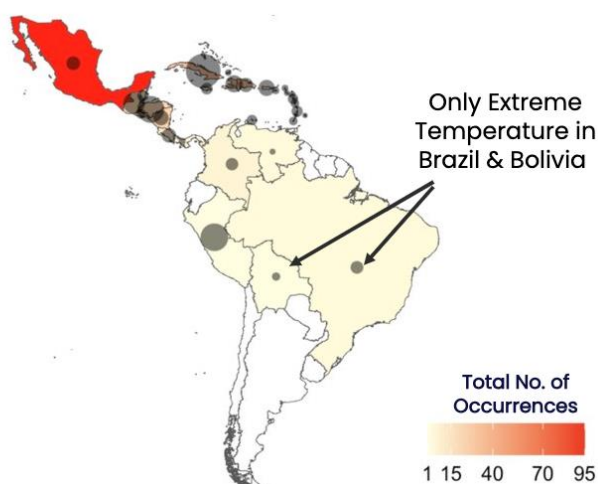


Figura 1: Número de casos de secas e incêndios florestais (parte superior), inundações e deslizamentos de terra (meio) e tempestades e temperaturas extremas (parte inferior) reportados entre 1991-2022. A legenda em vermelho representa o número total de ocorrências de cada categoria de risco entre 1991-2022, sendo o tamanho do círculo negro representativo da população média afetada nesse período.

Inundações Anteriores

As inundações e deslizamentos de terra ocorreram com maior frequência no Brasil, seguido pela Colômbia, com 78 e 74 riscos registrados entre 1991-2022 (Figura 1, meio) nos dois países, respectivamente. Os países com maior número de pessoas afetadas incluem a República Dominicana, onde 167.000 pessoas foram afetadas por 19 desses eventos hidrológicos. Da mesma forma, a Colômbia teve aproximadamente 155.000 pessoas afetadas por 74 desses eventos durante este período.

Temperaturas Extremas (Quente) e Tempestades Anteriores

O número de tempestades e temperaturas extremas foi particularmente elevado no México, com 92 ocorrências de tais eventos afetando quase 94.000 pessoas entre 1991-2022 (Figura 1, parte inferior). Cuba e Honduras são os países com a população mais afetada por estes eventos meteorológicos. Enquanto cerca de 970.000 pessoas foram afetadas em média por 31 desses eventos em Cuba, Honduras registrou cerca de 545.000 pessoas afetadas por 19 eventos durante o mesmo período. Apenas dados sobre temperaturas extremas (não tempestades) foram reportados para o Brasil e Bolívia no EM-DAT.

Projeções Futuras

As projeções futuras são baseadas no meio do cenário de emissões rodoviárias (SSP2-4.5 Caminho Socioeconômico Compartilhado) do multi-modelo das GCMs, Projeto de Comparação de Modelo Acoplado - Fase VI (CMIP6), fornecido no IPCC, em 2021². Embora não seja o pior cenário possível de emissões, o SSP2-4.5 presume que os compromissos do Acordo de Paris de 2015 não são cumpridos e o aquecimento global de 2°C não é evitado. As GCMs têm sensibilidade climática variável e geralmente também diferem em sua representação dos processos do sistema terrestre. Embora suas projeções na intensidade de um risco particular no futuro possam, portanto, diferir, apesar de um sinal persistente em registros históricos observados, a direção do sinal (ou seja, uma mudança positiva ou negativa de um risco climático) são geralmente mais robustas em todas as CGMs.

- **Temperaturas médias e extremas:** As projeções mostram que a mudança média na proporção de terras expostas a ondas de calor em 2030 em relação a 1986-2005 apresentam as regiões tropicais da América do Sul, da América Central, Cuba e as regiões costeiras do México são as mais expostas a tais perigos (confiança média) (Figura 2a). No entanto, as tiras cinzas em todos os modelos da Figura 2 indicam que não há concordância suficiente entre os modelos climáticos.
- **Secas e incêndios florestais:** Essas projeções também mostram que as proporções de terras mais propensas a serem expostas a um aumento de incêndios florestais são no norte da Argentina, as regiões mais populosas do Brasil e áreas do México (alta confiança) (Figura 2b).
- **Precipitação intensas e inundações:** Prevê-se que a intensidade e a frequência das precipitações extremas e das enchentes aumentem (confiança média) o nível do aquecimento global em 2°C ou mais (IPCC, 2021). A mudança prevista na precipitação anual total para 2030 usando dados de 1986-2005 mostra que o aumento das chuvas será maior na América do Sul (Figura 2c) (média a alta confiança). No entanto, a América Central e as ilhas do Caribe são as mais propensas a experimentar um declínio da precipitação média (baixa confiança).
- **Aumento do nível do mar:** É extremamente provável que o aumento relativo do nível do mar continue nos oceanos ao redor da América Central e da América do Sul, contribuindo para o aumento das inundações costeiras em áreas de baixa altitude (alta confiança) e recuo do litoral ao longo da maioria das costas arenosas (alta confiança).
- **Ciclones tropicais:** Os modelos em geral projetam um aumento na frequência e na intensidade dos ciclones tropicais de categoria 4-5 nesta região (confiança média). Embora a distribuição (indicando

o intervalo de mudança entre os modelos) seja ampla, prevê-se que o aumento médio seja de cerca de 3% em relação a 1986-2005.

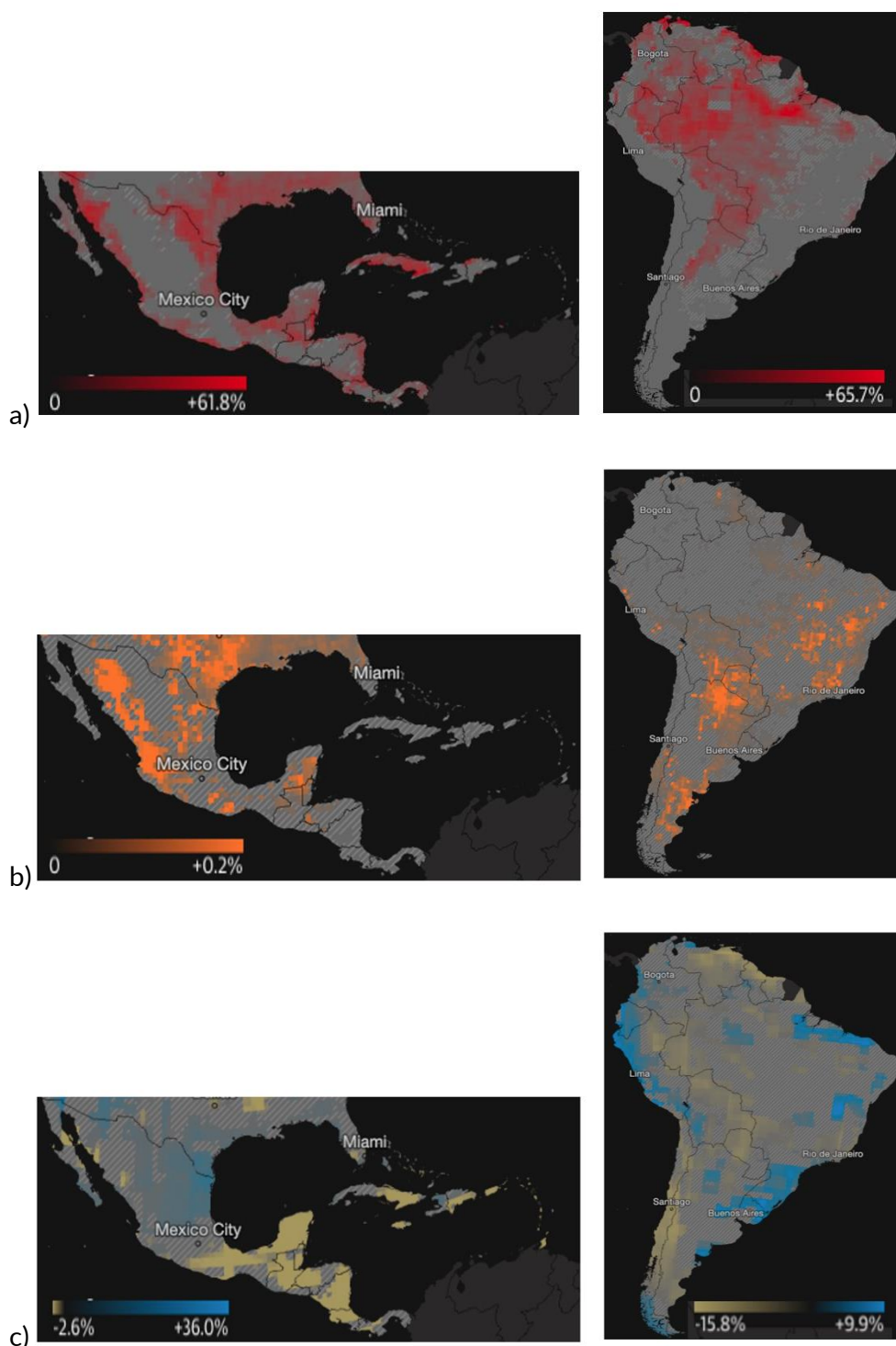


Figura 2. Mudanças projetadas em a) terrenos expostos a ondas de calor b) terrenos expostos a incêndios florestais e c) precipitação anual total em 2030 em comparação com 1986-2005 no cenário SSP2-4.5.

Nota: Informações detalhadas [sobre as projeções e a confiança associada](#) podem ser consultadas na contribuição do Grupo de Trabalho I para o Sexto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) "Climate Change 2021: The Physical Science Basis", [no atlas interativo do IPCC](#)

[WGI](#) e nas fichas técnicas regionais associadas: [Fichas técnicas - Mudança Climática 2021: The Physical Science Basis \(ipcc.ch\)](#) [EM-DAT - A base de dados internacional de desastres \(emdat.be\)](#)

Referências

- ¹ Allen, C., Beagley, J. & McGushin, A. *Climate Change and Health in Small Island Developing States*. (The Lancet Countdown on Health and Climate Change, 2021).
- ² Macpherson, C. C. & AKINAR-Elci, M. Caribbean Heat Threatens Health, Well-being and the Future of Humanity: Table 1. *Public Health Ethics* **8**, 196–208 (2015).
- ³ Rataj, E., Kunzweiler, K. & Garthus-Niegel, S. Extreme weather events in developing countries and related injuries and mental health disorders - a systematic review. *BMC Public Health* **16**, (2016).
- ⁴ Azuero, A. J. *et al.* Suicide in the Indigenous Population of Latin America: A Systematic Review. *Revista Colombiana de Psiquiatria* **46**, 237–242 (2017).
- ⁵ Kelman, I. *et al.* A review of mental health and wellbeing under climate change in small island developing states (SIDS). *Environ. Res. Lett.* **16**, 033007 (2021).
- ⁶ Guo, Y., Wen, B., Wu, Y., Xu, R. & Li, S. Extreme temperatures and mortality in Latin America: Voices are needed from the Global South. *Med* **3**, 656–660 (2022).
- ⁷ Allen, C., Beagley, J. & McGushin, A. *Climate Change and Health in Small Island Developing States*. (The Lancet Countdown on Health and Climate Change, 2021).
- ⁸ Rojas-Rueda, D., Vaught, E. & Buss, D. Why a New Research Agenda on Green Spaces and Health Is Needed in Latin America: Results of a Systematic Review. *IJERPH* **18**, 5839 (2021).
- ⁹ Mascayano, F. *et al.* Suicide in Latin America: a growing public health issue. *Revista de la Facultad de Ciencias Medicas* **72**, 295–303 (2015).
- ¹⁰ Parry, L. *et al.* The (in)visible health risks of climate change. *Social Science & Medicine* **241**, 112448 (2019).
- ¹¹ Daray, F. M. *et al.* Determinants and geographical variation in the distribution of depression in the Southern cone of Latin America: A population-based survey in four cities in Argentina, Chile and Uruguay. *Journal of Affective Disorders* **220**, 15–23 (2017).
- ¹² World Health Organization (WHO). *Mental health and climate change: policy brief*. (World Health Organization, 2022).
- ¹³ Lawrance, E. L., Thompson, R., Newberry Le Vay, J., Page, L. & Jennings, N. The Impact of Climate Change on Mental Health and Emotional Wellbeing: A Narrative Review of Current Evidence, and its Implications. *International Review of Psychiatry* **34**, 443–498 (2022).
- ¹⁴ Roland, J., Kurek, N. & Nabarro, D. *Health in the climate crisis: A guide for health leaders*. (World Innovation Summit for Health, 2020).
- ¹⁵ Hickman, C. *et al.* Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey. *The Lancet Planetary Health* **5**, e863–e873 (2021).
- ¹⁶ Chen, S. X., Lee, M., McVea, D. A. & Henderson, S. B. Risk of mortality among people with schizophrenia during the 2021 heat dome. *British Columbia Medical Journal* **65**, 158–9.

- ¹⁷ Page, L. A., Hajat, S., Kovats, R. S. & Howard, L. M. Temperature-related deaths in people with psychosis, dementia and substance misuse. *Br J Psychiatry* **200**, 485–490 (2012).
- ¹⁸ Woodland, L., Ratwatte, P., Phalkey, R. & Gillingham, E. L. Investigating the Health Impacts of Climate Change among People with Pre-Existing Mental Health Problems: A Scoping Review. *IJERPH* **20**, 5563 (2023).
- ¹⁹ Charlson, F. *et al.* Climate Change and Mental Health: A Scoping Review. *IJERPH* **18**, 4486 (2021).
- ²⁰ World Health Organization (WHO). 2021 *WHO Health and Climate Change Survey Report*. (World Health Organization, 2021).
- ²¹ Romanello, M. *et al.* The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels. *The Lancet* **400**, 1619–1654 (2022).
- ²² Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. (Cambridge University Press, 2023).
- ²³ Knutson, T. *et al.* Tropical Cyclones and Climate Change Assessment: Part II: Projected Response to Anthropogenic Warming. *Bulletin of the American Meteorological Society* **101**, E303–E322 (2020).
- ²⁴ WHO. *Climate Change and Health in Small Island Developing States: WHO Special Initiative in collaboration with UNFCCC Secretariat and Fijian Presidency of COP-23*. 1–18 www.who.int/publications/m/item/climate-change-and-health-in-small-island-developing-states (2018).
- ²⁵ Centre for Epidemiology and Evidence. *Setting Research Priorities: A Guide*. (Population and Public Health Division, NSW Ministry of Health, 2023).
- ²⁶ CRED. EM-DAT: The International Disaster database. <https://www.emdat.be/> (2023).